ВЕРСИЯ 2 · ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА И МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Клинический компас

Научно-клиническое обоснование, архитектура первичного психиатрического скрининга и техническое задание на разработку цифровой системы поддержки пациента и специалиста

Проект Даны и Полины · 17 октября 2026 года. Расширенная редакция прежнего плана с учетом нового ТЗ, десяти изображений, PHQ-ADS и присланной формы HCL-33.

Идея Даны. Человеку легче сообщать о сложных переживаниях, когда он понимает смысл вопросов, правила конфиденциальности и дальнейшие действия специалиста. Сервис дает объяснения по запросу, сохраняет право отказаться и помогает подготовить разговор о состоянии.

Первая аудитория	Основной маршрут	Граница ответственности
Студенты и молодые взрослые; MVP для 18+. Понятные материалы полезны и другим взрослым.	Вступление → FAQ по желанию → согласие → безопасность → PHQ-4 → назначенные полные шкалы → специалист.	Программа фиксирует данные и считает шкалы. Подготовленный специалист оценивает состояние и решает, какая помощь нужна.

Статус документа

Это законченная спецификация исследовательского прототипа, а не готовое медицинское изделие. Семейное древо исключено из первой версии. Клинические сценарии демонстрируются на учебных данных; условия реального применения перечислены отдельно.

Источники: [16], [21], [22], [25], [26].

Содержание и быстрые переходы

Быстрый переход	Страница
Вступление и FAQ	8
Вопрос специалисту и согласие	11
Общий маршрут и безопасность	13
PHQ/GAD и общий показатель	17
Дополнительные шкалы и видео	22
Техническое задание и приемка	26
MVP и будущие идеи	31
Русские формы и реестр	34
Чтение и библиография	44

Для первого обсуждения: вступление, FAQ и согласие, затем техническое задание и план MVP. Формы, реестр и источники доступны для последующей работы.

Как читать план и что изменилось

Раздел	Практический смысл
Идея и исследования	Развести наблюдения, рекомендации авторов и гипотезы интерфейса; сохранить статьи для Даны.
Экран доверия, FAQ и вопросы	Дать короткое вступление и раскрываемые пояснения до скрининга. Не требовать чтения всего FAQ.
Безопасность и шкалы	C-SSRS отдельно; PHQ-4 как короткий вход; PHQ-9/GAD-7 и PHQ-ADS; HCL-33 и врачебные формы по назначению.
Разработка и проверка	Данные, состояния, роли, действия при ошибке, тестовые сценарии и критерии готовности.
Формы, источники и изображения	Три полные русские формы PHQ/GAD; присланная HCL-33; реестр всех шкал; аннотированные ссылки и исходные материалы.

Четыре уточнения к первоначальной идее

• **Раннее объяснение полезно как проектный принцип.** Его влияние на доверие и обращение за помощью нужно измерять, не объявлять доказанным заранее.

• **Неодинаковые потребности поддерживаем выбором.** Короткий основной экран, раскрываемые пояснения, текст или голос и возможность остановиться.

• **Анонимность и конфиденциальность описываем точно.** Вопрос, связанный с аккаунтом, не называем анонимным. Абсолютную тайну и отсутствие госпитализации не обещаем.

• **Образование не должно становиться давлением.** Объясняем, зачем рассказать о переживаниях и какая поддержка возможна. Не требуем доказать, что пациент «понимает последствия».

Для первого обсуждения Полине достаточно прочитать вступление, маршрут, модель данных, критерии приемки и страницу «Над чем еще поработать». Библиография предназначена для дальнейшей медицинской работы Даны.

Используем «специалист» в общих экранах. При записи и передаче данных указываем точную роль: врач-психиатр, врач-психотерапевт или психолог. Права и задачи этих ролей не смешиваем.

Почему люди могут не говорить о мыслях

Основная статья: McGillivray и соавт., Non-disclosing youth (2022), DOI 10.1186/s12888-021-03636-x. Австралийский поперечный онлайн-опрос: 513 человек 16-25 лет, с мыслями о суициде и контактом со специалистом за предыдущие 12 месяцев. 39% не сообщали эти мысли своему специалисту.

Изучались самоотчеты, симптомы, история попыток, стигма и рабочие отношения со специалистом; использовалась логистическая регрессия. Выборка набрана через социальные сети. Это не репрезентативная выборка всех студентов и не проверка причинного эффекта приветственного экрана.

Что можно сказать	Чего исследование не устанавливает
Недоверие, страх последствий и отсутствие прямого вопроса могут мешать раскрытию.	Что молчание всегда означает недостаток осведомленности или что человек не понимает опасности.
С историей попыток раскрытие встречалось чаще; качество альянса связано с раскрытием.	Что отсутствие попытки означает безопасность или объясняет мотив конкретного пациента.
Участники назвали условия, при которых готовы говорить откровеннее.	Что выполнение пожелания автоматически повысит раскрытие или снизит частоту суицидального поведения.

Отдельная работа Blanchard и Farber

Статья «It is never okay to talk about suicide» опубликована онлайн в 2018 году, в выпуске журнала - в 2020-м. Авторы анализировали свободные ответы 66 клиентов психотерапии, скрывавших мысли. Это другой дизайн и другая выборка; присланная таблица процентов относится к McGillivray, а не к ней.

Позиция Даны в уточненном виде: объяснение может помочь некоторым людям рассказать о состоянии раньше. Одновременно человек вправе бояться последствий, сомневаться в доверии и быть не готовым говорить. Интерфейс учитывает эти разные причины.

Слово «нормативный» не используем в сообщении о безопасности. Распространенность мыслей среди подростков не делает их безопасными и не означает неизбежного перехода к действиям. Наличие мыслей - повод спокойно обсудить потребность в помощи, включая отсутствие намерения действовать.

Источники: [16], [17].

От результатов исследования к интерфейсу

Таблица 3 McGillivray и соавт.: проценты рассчитаны от N=513; допускался выбор нескольких вариантов. Они не складываются в 100% и не являются вероятностью того, что функция приложения сработает.

Что повысило бы готовность рассказать	n (%)	Проектное решение
Конфиденциальность	340 (66,3%)	Ясно показать доступ к ответам и пределы конфиденциальности.
Прямой вопрос специалиста	278 (54,2%)	Сохранять прямую формулировку выбранной шкалы.
Уверенность в возможности помощи	274 (53,4%)	Объяснить путь к помощи и доступные действия.
Реакция без осуждения	269 (52,4%)	Спокойный текст и обучение специалиста.
Усиление мыслей	267 (52,0%)	Пояснить возможность обратиться до ухудшения.
Влияние на учебу, работу, отношения	241 (47,0%)	Спросить о влиянии на жизнь без требования «достаточно тяжелого» состояния.

Причины не раскрывать мысли	n (%)
Опасение нарушения конфиденциальности	133 (25,9%)
Другие проблемы мешают сильнее	81 (15,8%)
Ожидание, что мысли сами пройдут	80 (15,6%)
Ожидание осуждения / мысли стали привычными	74 (14,4%) / 74 (14,4%)
Убеждение, что специалист не поможет	65 (12,7%)
Специалист не спрашивал прямо	61 (11,9%)
Негативная реакция в прошлом / другие причины	25 (4,9%) / 18 (3,5%)

Это сокращенная русская передача присланной таблицы; полная таблица доступна по ссылке: открыть таблицу 3. Страх госпитализации выделялся и в свободных ответах; пожелание гарантии ее отсутствия нельзя превращать в обещание сервиса.

Источники: [16].

Какие подходы уже изучались

Исследование и дизайн	Результат / полезный вывод	Ограничение для проекта
Gould, 2005 [18] РКИ, 2342 школьника	Не обнаружено увеличения суицидальных мыслей из-за скрининговых вопросов.	Школьный скрининг с исследовательской организацией; не гарантия для любого цифрового сценария.
Ford, 1997 [20] РКИ, 562 подростка	Объяснения конфиденциальности повышали заявленную готовность раскрывать чувствительные сведения.	Измерялись намерения; абсолютную конфиденциальность обещать нельзя.
King, 2015 [21] Пилотное РКИ, 76 студентов	Онлайн-обратная связь и контакт с консультантом дали обнадеживающие данные по обращению за помощью.	Небольшой пилот; нельзя переносить результат на один FAQ.
King, 2022 [22] РКИ, 3363 студента, 4 вуза	В основном анализе по назначенному вмешательству эффект eBridge на получение помощи не подтвержден.	Вовлечение - отдельная проблема. Результаты активных пользователей не равны эффекту рандомизации.
Pistorello, 2020 [23] РКИ CAMS, 62 студента	Пример совместной клинической работы; предварительные данные о снижении ряда симптомов.	Короткое исследование 4-8 недель; полноценная терапия подготовленным специалистом.
Karver, 2018 [24] Метаанализ: 28 работ, 2419 участников	Связь альянса с дальнейшим результатом: r=0,19.	Ассоциация не доказывает лечебный эффект интерфейса.

Ответ на вопрос Даны «есть ли разработанный подход?» Да: совместная работа с суицидальными переживаниями, мотивационный стиль беседы, план безопасности и прозрачное обсуждение конфиденциальности имеют научные и методические основания. Цифровой экран может поддержать эти процессы; он не воспроизводит всю терапию.

Точное исследование, где произнесение слов «депрессия» или «детская травма» само по себе улучшало раскрытие, по имеющемуся описанию не установлено. Идею понятных пояснений сохраняем как проектную гипотезу, не приписывая ей вымышленную публикацию.

Источники: [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Психологические принципы: в действиях

Подход	Как выглядит в продукте	Статус обоснования
Помощь с учетом травматического опыта	Заранее объяснять действия, не требовать подробного рассказа, давать выбор способа ответа и остановки.	Рамка SAMHSA [25]. Эффект конкретного экрана нужно проверять.
Совместное принятие решений	Показать, что предлагается и почему; дать задать вопрос, обсудить варианты и выразить предпочтение.	Рекомендации NICE [26]; медицинские решения остаются у специалиста с участием пациента.
Мотивационное интервьюирование	Спрашивать разрешение на дополнительное пояснение, признавать сомнения, не спорить и не стыдить за отказ.	Принципы применялись в eBridge [21,22]; набор фраз не делает приложение терапевтом.
Психообразование	Коротко объяснять понятие, назначение вопроса и путь к поддержке; дополнительные сведения по запросу.	Поддерживается найденными данными о барьерах; лечебный эффект именно нашего FAQ не проверен.
Коммуникация с учетом человека	Не оценивать характер; учитывать язык, доступность, усталость, прежний негативный опыт и личные цели.	Принцип проектирования и клинического взаимодействия, не отдельный диагностический метод.

Двухуровневый язык

Сначала короткое объяснение простыми словами: «Мы спросим о настроении, тревоге и мыслях о смерти. Это поможет понять, какая поддержка может быть полезна». Затем - точный стандартизированный вопрос. Кнопка «Что означает этот вопрос?» открывает проверенное пояснение, отдельно от текста шкалы.

> Слова могут тревожить; это не надо отрицать. Подходящая фраза: «Клинический термин описывает переживание или симптом. Он не определяет вашу ценность и сам по себе не означает, что вам уже поставили диагноз». Для депрессии, мыслей о смерти и самоповреждения даются отдельные пояснения.

Терапевтический альянс включает доверие, согласование целей и сотрудничество в ходе реальной работы. Один экран может сделать правила понятнее; полноценные рабочие отношения складываются во взаимодействии со специалистом.

Источники: [16], [24], [25], [26].

Первый экран: готовый текст

Здесь можно рассказать о своем состоянии

Иногда трудно подобрать слова для того, что с нами происходит. Мы спросим о настроении, тревоге и мыслях о смерти. Ответы помогут подготовиться к разговору со специалистом.

Здесь нет «правильных» ответов. Можно открыть пояснение, оставить комментарий или остановиться. До отправки мы покажем, кто получит ответы и как они защищаются.

Если помощь нужна сейчас, воспользуйтесь отдельной кнопкой помощи.

Главные действия	Поведение
Начать	Открыть информацию о данных и согласии; не отправлять медицинские ответы до определения правового основания.
Сначала разобраться	Открыть FAQ, не требуя регистрации для чтения.
Мне нужна помощь сейчас	Доступно постоянно, включая приветствие и страницу согласия. Не требует завершения тестов.

Почему изменен первоначальный текст

Фраза «не для того, чтобы оценивать» может путать: сервис помогает оценить состояние. Лучше убрать оценку личности из общения и прямо назвать медицинскую цель. Обещания «здесь абсолютно безопасно» или «все останется только между нами» не соответствуют неопределенным условиям будущего сервиса.

FAQ не показывается целиком по умолчанию. На первом экране достаточно трех раскрываемых тем: кто увидит ответы, что произойдет после сложного ответа и можно ли остановиться. Остальные вопросы доступны в поиске или списке.

Текст выше - проектный вариант для тестирования. Перед публикацией оператор обязан подставить реальные сведения о получателях, защите и канале помощи. Необходимые сведения нельзя заменить общим обещанием заботы.

Источники: [16], [20], [25], [26], [31], [32].

FAQ перед опросом: безопасность и доверие

Если я расскажу о тяжелых мыслях, меня сразу госпитализируют?

Нет автоматической связи между одним ответом и госпитализацией. Специалист уточнит состояние и обсудит помощь. При серьезной опасности может потребоваться срочная помощь; решение принимают по клинической ситуации и закону.

Кто увидит мои ответы?

Перед отправкой сервис должен назвать медицинскую организацию, ответственного специалиста и других сотрудников, которым нужен доступ для помощи. Данные не становятся публичными. Правила и исключения конфиденциальности доступны до согласия.

Могу ли я пропустить вопрос?

Да, можно отказаться или остановиться. В вопросах безопасности есть действие «Не готов(а) отвечать» и отдельная возможность поговорить со специалистом. Отказ не будет записан как «нет»; оценка останется незавершенной.

Может ли приложение поставить диагноз?

Опросники описывают симптомы и помогают специалисту подготовиться к беседе. Диагноз и план помощи определяет квалифицированный специалист с учетом клинической оценки.

Что делать, если помощь нужна прямо сейчас?

Откройте «Мне нужна помощь сейчас». При непосредственной опасности нужна местная экстренная помощь; не ждите ответа на обычное сообщение или завершения анкеты.

Узнают ли родители или университет?

Для совершеннолетнего пользователя сервис не предусматривает автоматической отправки ответов родителям или университету. Передача сведений требует надлежащего основания. Закон предусматривает отдельные исключения из конфиденциальности; они должны быть объяснены.

Тексты адаптированы для первой версии 18+. Для несовершеннолетних необходим отдельный сценарий с проверкой правил согласия, представительства и информирования; переносить эти ответы без проверки нельзя.

Источники: [5], [7], [16], [20], [31], [32], [33].

FAQ: переживания, термины и лечение

Что такое депрессия? Это значит, что со мной что-то не так?

Депрессия - название состояния, которое может влиять на настроение, интерес к жизни, энергию и повседневные дела. Это не оценка характера. Симптомы требуют разбирательства; один результат анкеты диагнозом не является.

Обязательно ли назначат антидепрессанты?

Один балл теста не определяет лечение. Специалист обсуждает состояние, подходящие варианты, ожидаемую пользу, ограничения и ваши предпочтения. Самостоятельно начинать или менять лечение по результату приложения не нужно.

Может ли специалист осудить меня за мои мысли?

Профессиональная помощь должна быть уважительной. Можно прямо сказать, что вы боитесь реакции. Если общение задело вас, это можно обсудить или обратиться к другому специалисту.

Нужно ли рассказывать о мыслях о смерти, если я не собираюсь действовать?

Рассказать полезно и без намерения причинить себе вред: специалист сможет лучше понять переживания и обсудить поддержку. Наличие мыслей, намерение, план и действия - разные сведения.

Что делать, если мысли стали привычными?

Привычность не показывает, насколько состояние безопасно или нужна ли помощь. Можно обсудить эти мысли со специалистом, даже если они существуют давно и не стали сильнее.

Почему обращаться до ухудшения?

Поддержку можно искать до серьезных нарушений учебы, работы или отношений. Для обращения не нужно ждать, пока станет «достаточно плохо».

Что делать, если я не готов(а) отвечать откровенно?

Можно остановиться, задать вопрос о правилах или обсудить тему непосредственно со специалистом. Сервис сохраняет отказ как отказ и не делает вывод, что переживаний нет.

Различаем: мысли - содержание переживаний; намерение - готовность действовать; план - сформированные представления о действиях; поведение - совершенные или подготовительные действия. Оценка специалиста учитывает контекст и актуальность, а не только эти названия.

Источники: [3], [5], [7], [11], [16], [26], [27].

Вопрос до обследования: два разных сервиса

Модель	Как работает	Что нельзя обещать
Библиотека FAQ до регистрации	Проверенные специалистом общие ответы. Поиск по темам. Не запрашивать личную историю для простого чтения. Технические журналы описаны отдельно.	Чтение без аккаунта не гарантирует отсутствия любых технических следов.
Конфиденциальный вопрос из аккаунта	Человек выбирает специалиста и видит время ответа. Вопрос связан с аккаунтом и журналируется; публикации в общем FAQ нет.	Не называть анонимным и не выдавать обычную переписку за экстренный канал.
Отдельная анонимная очередь - версия 2	Без связи с аккаунтом; случайный код для чтения ответа; минимизация журналов и идентификаторов, отдельная проверка архитектуры. Просьба не включать ФИО и контакты в текст.	Нельзя обещать истинную анонимность без проверки логов, аналитики, адресов и содержимого вопроса. Нельзя обещать найти человека при опасности.

Нужен работающий процесс ответа

Очередь имеет ответственного, модерацию, фактическое расписание и срок ответа. До открытия формы отображаются эти сведения и указание, что канал не подходит для срочной помощи. Передача вопроса и прочтение специалистом - отдельные статусы. Анонимный вопрос не переносится автоматически в медицинскую карту.

Уточнение идеи Даны. Возможность получить ответ без раскрытия личности может снизить барьер. Это не означает сбор данных «без согласия человека». Пользователь должен понимать, что отправляет и как будет использован текст. Общий ответ на чужой вопрос можно читать без прохождения скрининга.

При сообщении об опасности специалист действует в пределах доступных сведений и протокола. Если контакт отсутствует, удаленно установить личность может быть невозможно. Такое ограничение объясняется заранее; автоматический поиск личности и обещание спасения по анонимной заявке в MVP не включаются.

Источники: [16], [20], [21], [22], [31], [32].

Согласие и конфиденциальность: содержание

Что объяснить до отправки	Что подготовить для реализации
Цель и участники	Назвать оператора, медицинскую организацию, ответственного специалиста и цель обработки каждого набора данных.
Доступ к ответам	Определить роли, основания доступа, получателей и журнал просмотров. Доступ университета как к индивидуальным результатам не предусматривается.
Хранение и передача	Зафиксировать место основных и резервных баз, сроки, обработчиков, порядок экспорта и удаления. Для данных граждан РФ проверить применимые требования ст.18 152-ФЗ.
Голос и расшифровка	Запись необязательна; показать, кто обработает аудио и текст, где они окажутся и сколько хранятся. Нельзя незаметно отправлять их внешнему ИИ-сервису.
Право отказаться и отозвать	Показать канал отзыва, последствия для дальнейшей работы и применимые основания продолжения хранения медицинской документации. Не обещать безусловное мгновенное удаление всего.
Исключения и помощь	Объяснить законные пределы конфиденциальности и процедуру при опасности. Отказ от раскрытия не равен отрицательному ответу.
Автоматизация	Описать расчет шкал; ИИ, если он появится, используется для вспомогательной работы с текстом после отдельной проверки.

Правовые ориентиры

152-ФЗ: согласие оформляется отдельно от других подтверждаемых документов; данные о здоровье относятся к специальным категориям и требуют определения надлежащего правового основания. Нельзя считать любую галочку достаточной для любого вида медицинской обработки. 323-ФЗ: врачебная тайна, согласие на медицинское вмешательство и правила медицинской помощи. Это разные вопросы, их не следует прятать в одном общем «Принимаю все».

Пределы раскрытия определяются законом и конкретной ситуацией. Приложение не дает произвольного разрешения делиться сведениями с близкими при любом положительном ответе. Для несовершеннолетних разрабатывается отдельный порядок.

До запуска заполнить реальные сведения об операторе, юридических основаниях, сроках хранения и получателях. В этом документе они не выдумываются: это открытые задачи команды и медицинского партнера.

Источники: [31], [32], [33].

Полный маршрут: 17 шагов

Нумерация соответствует приложенному ТЗ. Первые информационные шаги короткие и необязательные для чтения целиком. Вопросы безопасности не откладываются из-за ожидания ответа в FAQ.

1-4. Знакомство

Приветствие, FAQ и вопрос по желанию. Срочная помощь доступна сразу.

↓

5. Информация и согласие

Показать получателей, данные и правила. Отказ оставляет доступ к общим материалам.

↓

6-7. C-SSRS и действия безопасности

Официальная выбранная версия. При срочной ситуации перейти к помощи без ожидания тестов.

↓

8-11. PHQ-4 и полные формы

Раздельные PHQ-2/GAD-2; предложение системы и назначение специалиста.

↓

12-13. Сводка

PHQ-9, GAD-7; PHQ-ADS при полных сопоставимых данных. Комментарии и пропуски отдельно.

↓

14-17. Клиническая работа

Прием, видео при необходимости; MADRS/HDRS-17/HCL-33 по назначению; план наблюдения.

Три независимые оси. 1) состояние безопасности и действия команды; 2) результаты самоопросников; 3) клиническая оценка специалиста. Завершение одной оси не подменяет другую.

Доступность: мобильный экран, крупные элементы, достаточный контраст, управление с клавиатуры и программой чтения. Смысл не кодировать только цветом. Прогресс учитывает ветвление; структурно не заданный вопрос не показывается как ошибка. Цветовая тема - дополнительная настройка.

Источники: [5], [7], [25], [26], [27].

C-SSRS: версия и ветвление

Для короткого входа выбирается конкретная шестипунктовая форма, например официальный амбулаторный Screener. Полная C-SSRS содержит более подробные разделы тяжести, интенсивности и поведения; она не является тем же опросом с другим оформлением.



Часть краткой формы	Период и сохранение
Вопросы 1-5	В выбранной амбулаторной форме - последний месяц. Записывать реальный ответ и период.
Вопрос 6	За жизнь; при положительном ответе отдельно уточнять последние три месяца.
Вопросы 3-5 при ответе «нет» на 2	Статус not_asked_by_rule; значение пустое. Не записывать три отрицательных ответа.
Вопрос 2 не отвечен	Не считать правилом «нет». Сохранить неопределенность ветви и предложить помощь специалиста.

Официальная русская версия

Columbia указывает русскоязычные переводы и отдельные self-report формы. Русская C-SSRS присутствует в доступной редакции рекомендаций по БАР 2025 года, приложение Г1; это не подтверждает совпадение с выбранным шестипунктовым самостоятельным экраном. До клинической реализации получить точную форму, дату, страну, назначение и условия ее цифрового использования.

Для обычного клинического применения Columbia разрешает встраивание в EHR на указанных условиях. Исследовательское и электронное применение нужно сопоставить с отдельными правилами. Собственный перевод, «мягкая» замена официального вопроса и автоматическая интерпретация аудио не объявляются валидированной C-SSRS.

Источники: [5], [6], [30], [36].

Безопасность: состояния и действия

Состояние процесса	Пациент и специалист	Резервный сценарий
Сигнал не выявлен при завершенном скрининге	Продолжить маршрут; показать дату и полноту. Не писать «риска нет».	Новые сведения или изменение состояния возвращают к оценке.
Нужно клиническое уточнение	Сообщить, что полезно обсудить ответы; специалист видит исходники и причину внимания.	Канал и срок уточнения задает клиника. При ухудшении доступна помощь сейчас.
Нужна срочная оценка	Выполнить согласованный клинический протокол; не удерживать человека в длинной анкете.	Ответственный дежурный / резерв клиники. Обычная очередь вопросов не подходит.
Непосредственная угроза	Показать краткий путь к местной экстренной помощи и действиям команды. Уведомление специалисту не заменяет помощь.	При недоступности специалиста - местная экстренная служба и утвержденный резерв.
Неполный скрининг / отказ	Статус «оценка не завершена», возможность связаться со специалистом и остановиться.	Не выдавать отрицательный результат и не закрывать доступ к помощи.

Кто и как определяет переход

Связь ответов с действиями фиксирует медицинский владелец в проверяемом протоколе. Это правила реагирования, не расчет вероятности суицида и не категории «низкий/средний/высокий» как прогноз. ИИ не решает вопрос о безопасности, лечении или госпитализации.

Уведомление должно быть наблюдаемым процессом: создано → передано → доставлено в рабочее место → подтверждено сотрудником → действие документировано. Нет подтверждения в согласованный интервал - включается резерв. Факт отправки push-уведомления не равен клиническому ответу.

При активном намерении/плане, недавнем поведении, иной клинической тревоге или положительном пункте 9 PHQ-9 сведения передаются для уточнения по протоколу независимо от суммы симптомов. На демонстрации ясно обозначать имитацию уведомления; не обещать, что настоящий специалист читает сообщения.

Источники: [5], [7], [27], [30].

Экран безопасности и памятка специалисту

Основные ответы: «Да» и «Нет». Дополнительные действия: «Не готов(а) отвечать» и «Остановить опрос». При отказе отдельно предложить «Поговорить со специалистом», сохранив право отказаться и от этого предложения. Неполнота фиксируется; отказ не считается ответом «нет» или самостоятельным доказательством опасности.

Элемент	Правило
Что означает этот вопрос?	Короткое клинически проверенное пояснение. Не скрывать прямой вопрос и не подсказывать ответ.
Комментарий / голос	Открывается по желанию в компактном меню. Обычные комментарии не создают обещания немедленного прочтения.
Обсудить лично	В блоке безопасности обозначить «нужно уточнение специалиста», без обещания безопасно отложить до планового приема.
Мне нужна помощь сейчас	Постоянная текстовая кнопка с доступным действием; маршрут выбирается по стране/региону и данным клинического партнера.

Краткая памятка рядом с результатом

• Уточнить актуальность переживаний, намерение, план, поведение, поддержку и возможность получить помощь. Не ограничиваться одним итогом шкалы.

• Спокойно объяснить цель вопросов и пределы конфиденциальности; уточнить страхи и прежний негативный опыт. Не обещать заранее отсутствие госпитализации.

• Сверить противоречия между формой и комментарием в беседе. Исходный ответ не удалять; клиническую запись вести отдельно.

• Зафиксировать дату, источник сведений, неполноту, действия, переданную информацию и план дальнейшей связи.

Что значил фрагмент статьи про обучение

Авторы обращают внимание и на комфорт самого специалиста: страх спросить или неуверенность в следующем шаге могут мешать расспросу. Обучение включает практику прямого вопроса, применение инструмента и действия после ответа. Памятка в приложении поддерживает обучение, но его не заменяет. Проверка безопасности может понадобиться повторно, поскольку состояние меняется.

Источники: [18], [19], [27], [37].

PHQ-4 и назначение полных опросников

Скрининг за 2 недели	Правило	Дальнейший шаг
PHQ-2: пункты 3+4 русской PHQ-4	0-6; скрининговый порог ≥3	Предложить специалисту PHQ-9.
GAD-2: пункты 1+2 русской PHQ-4	0-6; скрининговый порог ≥3	Предложить специалисту GAD-7.
Обе подшкалы ниже 3	Это не исключает расстройства	Полные формы доступны по назначению независимо от порога.
Одна подшкала не завершена	Не заменять пропуск нулем	Показать известную полноту; завершенную вторую подшкалу хранить отдельно.

Предложение и назначение

Для клинического режима система создает предложение. Полная форма открывается после назначения специалистом либо в рамках заранее утвержденного им пакета обследования. Так сохраняется быстрый путь до консультации без имитации автономного назначения. Во время видеоприема врач может добавить или изменить обследование.

Избежать лишнего ожидания. Клинический куратор может заранее назначить пакет «PHQ-4 с продолжением по порогам». Сервис выполняет согласованные правила этого пакета. Отдельное новое клиническое решение маркируется автором и временем.

Перенос совпадающих ответов

В одной сессии и одинаковом периоде PHQ-4 (3,4) совпадает с PHQ-9 (1,2), PHQ-4 (1,2) - с GAD-7 (1,2) в приложенных переводах. Можно предложить подтвердить перенос. При разных переводах, изменении ответа, новом периоде или визите перенос не выполняется молча. Для первого клинического пилота эквивалентность такого цифрового продолжения проверяется отдельно.

Общий PHQ-4 0-12 не заменяет две подшкалы при развилке. Его категории не используются для решения о срочности. Неполные ответы не пересчитываются пропорционально в стандартный итог.

Источники: [1], [2], [3], [4].

PHQ-9, GAD-7 и PHQ-ADS

Показатель	Расчет и диапазон	Рабочая интерпретация
PHQ-9	Сумма 9 ответов; 0-27	0-4 минимальные, 5-9 легкие, 10-14 умеренные, 15-19 умеренно тяжелые, 20-27 тяжелые симптомы. ≥10 - повод для клинической оценки.
GAD-7	Сумма 7 ответов; 0-21	0-4 минимальные, 5-9 легкие, 10-14 умеренные, 15-21 тяжелые тревожные симптомы. ≥10 не равняется диагнозу ГТР.
PHQ-ADS	PHQ-9 + GAD-7; 0-48	Дополнительная общая выраженность симптомов. Исходная статья: границы 10/20/30 для легкой/умеренной/тяжелой степени. Для этой русской реализации - исследовательский показатель.

Основание объединенного показателя

Kroenke и соавт. (2016): данные 896 пациентов трех клинических исследований, преимущественно по хронической боли и депрессии, включая онкологическую практику. Обнаружены конвергентная валидность (большинство корреляций 0,7-0,8) и связи с качеством жизни и ограничениями. Это не отдельный дополнительный опрос: используются уже полученные 16 ответов.

> Для PHQ-ADS нужны обе полные шкалы, совместимые версии, одна оценочная сессия и один временной интервал. Если одной шкалы нет или она неполная, PHQ-ADS не рассчитывается. C-SSRS в него не входит.

Важное ограничение

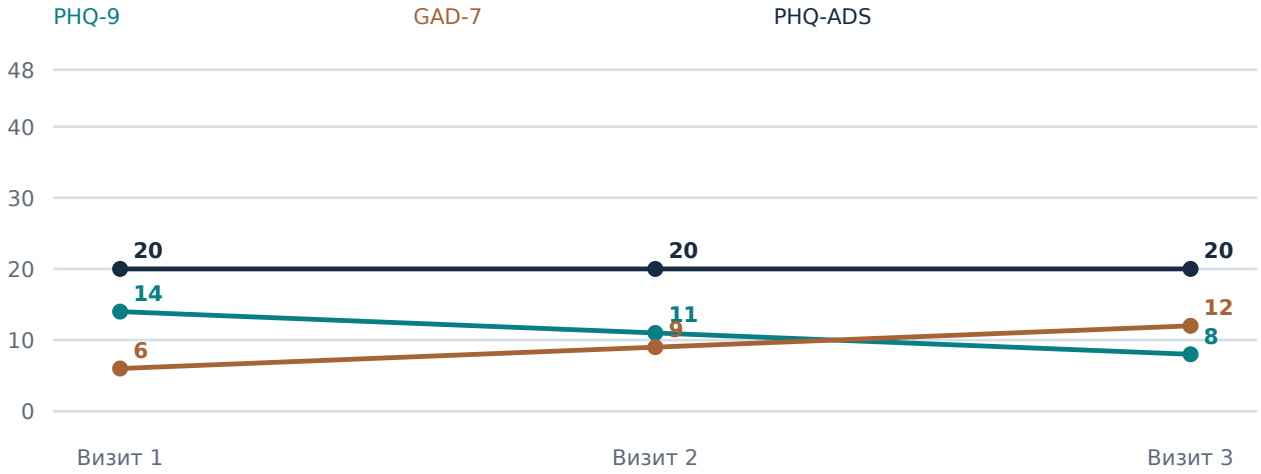
Психометрическая проверка отдельных русских PHQ-9 и GAD-7 не доказывает валидность их суммарного русскоязычного PHQ-ADS для студентов. В найденных источниках такая проверка именно выбранной пары переводов не подтверждена. На панели специалиста сохраняем все три показателя, четко обозначая исследовательский статус общего.

Пункт 9 PHQ-9 >0 или тревожная новая информация инициируют уточнение безопасности при любом PHQ-ADS. Значение 0 по этому пункту не исключает иных клинически значимых сведений.

Источники: [3], [4], [14], [15], [28].

Динамика: сумма может скрыть изменения

Учебные, вымышленные данные: по мере наблюдения PHQ-9 снижается, GAD-7 растет, а общий PHQ-ADS остается 20. Поэтому общий показатель не должен вытеснять отдельные шкалы.



Сохраняем для точки на графике	Правило
Название, версия и язык	Не смешивать разные переводы или модифицированные временные окна.
Дата, период и способ проведения	Сравнивать сопоставимые сессии; врачебную оценку и самоотчет показывать отдельно.
Полнота и подтверждения	Не соединять неполную анкету с полноценным итогом. Пропуск не является точкой 0.
Ответы, из которых получена сумма	При открытии точки доступны исходные пункты, комментарии и время изменения.
Клиническая интерпретация	Изменение балла не является автоматическим улучшением, ремиссией или основанием сменить препарат.

Рекомендуемая панель: PHQ-9, GAD-7, дополнительный PHQ-ADS и отдельная полоса событий безопасности. Срок повторения назначает специалист; ежедневное изменение периода двухнедельной анкеты нельзя вводить под тем же названием без проверки.

Источники: [3], [4], [28].

Комментарии, голос и роль ИИ

Слой данных	Что хранить и показывать
Самоотчет	Исходное значение, версия вопроса, период, время и история добровольных исправлений пациентом.
Комментарий	Оригинальный текст, связь с вопросом и признак «хочу обсудить». Отсутствие комментария не означает отсутствие проблемы.
Голос	Исходная запись, длительность, подтвержденное согласие, статус загрузки; например 60-90 секунд как настраиваемый лимит прототипа.
Расшифровка	Отдельный машинный черновик, версия распознавания, проверенный пациентом/специалистом текст и автор проверки. Исходник не подменять.
Работа специалиста	Наблюдения, уточнение и клинический вывод отдельно от ответа пациента. Индикатор непрочитанной дополнительной информации.

Что может делать ИИ после отдельной проверки

Распознать речь, предложить структуру комментария и список тем для уточнения. Все эти результаты маркируются как вспомогательные и доступны для исправления. Нельзя считать уверенность распознавания доказательством смысла фразы. Ошибка или отсутствие ИИ не должны блокировать исходные ответы и клиническую работу.

> ИИ не исправляет PHQ/GAD, не выставляет MADRS/HDRS, не классифицирует безопасность и не решает о госпитализации. Выделение потенциально тревожного фрагмента не заменяет стандартный маршрут реагирования и не гарантирует обнаружение всех опасных сообщений.

Практический пример

Пациент выбрал 0, но в комментарии описал переживание, которое кажется несовместимым с ответом. Специалист видит оба источника, задает уточняющий вопрос и документирует вывод. При добровольном изменении ответа сохраняется предыдущая версия; отдельное мнение врача не превращается в новый ответ пациента.

На MVP текст и флаг обсуждения можно включить раньше аудио. Голос добавляется при готовом хранении, порядке согласия и доступном времени специалиста. Заявлять, что голос обязательно повышает качество анамнеза, пока нельзя.

Источники: [3], [4], [31], [32].

Панель специалиста: структура

Раздел рабочего места	Минимальное содержание
Безопасность - видно первой	Дата и форма C-SSRS, вопросы и периоды, история поведения, пропуски, причина сигнала и статус ответа команды. Без прогнозного «рейтинга риска».
Симптоматика	PHQ-2/GAD-2, PHQ-9/GAD-7, дополнительный PHQ-ADS; полнота и динамика. Переход от суммы к отдельным пунктам.
Контекст ответа	Значок комментария/аудио, исходный текст, расшифровка, прослушивание и темы к беседе. Персональные заметки доступны по роли.
Назначения	Запланированные формы, автор назначения, срок, состояние выполнения; MADRS, HDRS-17, HCL-33 по необходимости.
Клиническое решение	Запись квалифицированного специалиста, основание, план, необходимость очного осмотра и дальнейшей связи.
История и контроль	Кто видел и изменял данные, подтверждения врачебных пунктов, предупреждение об устаревших/несопоставимых данных.

Пример карточки результата - учебные данные

Самоотчет: PHQ-9 12/27 (9/9), GAD-7 8/21 (7/7), PHQ-ADS 20/48 - исследовательский.
Безопасность: отдельная запись с датой и состоянием реагирования; это не оценка по сумме симптомов.
Уточнения: два комментария, одно аудио, одна тема для беседы.
Следующий шаг: специалист проверяет сведения и назначает обследование. Диагноз программой не сформирован.

Доступ к индивидуальным результатам не означает право отправлять их деканату, работодателю или всем сотрудникам клиники. Кабинет пациента показывает понятную сводку и дальнейшее действие; внутренние служебные уведомления и клинические черновики регулируются отдельно.

Источники: [7], [28], [31], [32].

MADRS: десять врачебных карточек

Шкала Montgomery-Asberg предназначена для оценки тяжести депрессивной симптоматики и динамики. Подготовленный специалист проводит интервью и использует критерии конкретной версии. Самоответ пациента из PHQ-9 не превращается автоматически в MADRS.

Пункты 1-5: содержание	Пункты 6-10: содержание
Видимая печаль	Трудности сосредоточения
Печаль со слов пациента	Снижение побуждения к деятельности
Внутреннее напряжение	Снижение способности переживать чувства
Сон	Пессимистические мысли
Аппетит	Суицидальные мысли

Критерии и подсчет

Для каждого пункта требуется точная русская формулировка и клинические опорные описания выбранной формы. Общая шкала каждого пункта 0-6; исходные опорные значения и промежуточные оценки трактуются по ее инструкции. Здесь дана карта содержания; она не заменяет защищенный/лицензируемый текст критериев.

> Карточка хранит: исходный текст критерия, выбранное значение, обоснование, статус «не оценено / черновик / подтверждено», специалиста и время. Начальное значение пустое. После изменения подтверждение снимается.

Итог MADRS 0-60 выводится после подтверждения всех 10 пунктов. До этого допустима только явно подписанная промежуточная сумма подтвержденных пунктов и полнота, например 8/10, без категории тяжести. Сохраняется журнал изменений.

Русская форма представлена в приложении Г2 проверенной редакции рекомендаций по депрессивному эпизоду/РДР 2024 года. Период и критерии берутся из выбранной инструкции; двухнедельный период PHQ автоматически не подставляется. Возможность показа полного текста в продукте проверяется отдельно.

Источники: [8], [10], [11].

HDRS-17: отдельная врачебная форма

Hamilton Depression Rating Scale, 17 пунктов: клиническая оценка депрессивных симптомов и динамики. Для стандартной 17-пунктовой формы общий диапазон 0-52; конкретная структура и критерии проверяются по выбранной русской форме.

Группы пунктов	Оцениваемые признаки	Стандартные диапазоны
1-3	Настроение, вина, суицидальность	Каждый 0-4
4-6	Ранняя, средняя и поздняя бессонница	Каждый 0-2
7-11	Работа/активность, заторможенность, ажитация, психическая и соматическая тревога	Каждый 0-4
12-14	Желудочно-кишечные и общие соматические, половые симптомы	Каждый 0-2
15	Ипохондрические проявления	0-4
16-17	Потеря массы тела, критика к состоянию	Каждый 0-2

Почему нельзя копировать интерфейс MADRS без изменений

У HDRS-17 собственные клинические критерии и неодинаковые диапазоны пунктов. Нужна отдельная схема данных, проверка разрешенных значений и учета конкретной версии. Поле, валидное для MADRS 0-6, не подходит для пунктов HDRS.

Экран специалиста: критерии из выбранного источника → обоснование → балл → подтверждение. Итог формируется после полной оценки; состояние «не оценено» сохраняется. Исходный самоотчет и врачебная оценка остаются разными сущностями.

Русская форма HDRS в проверенной редакции рекомендаций по депрессивному эпизоду/РДР 2024 года - приложение Г1. Баллы и категории других вариантов Hamilton (например, расширенных форм) не переносить без проверки. Выбор MADRS, HDRS или обеих шкал и частоту повторения определяет специалист.

Источники: [9], [10], [11].

Видеоприем: что подтверждено

Первичная работа	Сравнение и результат	Практический предел
Kobak и соавт., 2008 [8]	MADRS: видео/очно, N=35, ICC=0,94; отдельное телефонное сравнение N=35, ICC=0,93.	Небольшие исследования подготовленных оценщиков. Это не проверка ИИ-анализа лица или голоса.
Kobak, 2004 [9]	HAMD: видео и очное интервью в одной группе N=21; ICC=0,88.	Важны техника, процедура и подготовка специалиста; результат не доказывает эквивалентность любого видеосервиса.
Kølbæk и соавт., 2025 [10]	Тренинг HAM-D17, 110 сотрудников: точность в допустимом отклонении от эталона 43% → 70%.	Это подготовка оценщиков, не сравнение видео и очного лечения.

Предлагаемый сценарий видеоконсультации

• До приема - назначенные формы и сведения, которые специалист реально успеет просмотреть.

• В начале - личность, местонахождение, приватность и договоренность при обрыве связи; оценка того, подходит ли дистанционный формат.

• Во время - клиническая беседа, уточнение комментариев, наблюдения и при необходимости подтверждение пунктов MADRS/HDRS.

• После - заключение и план специалиста, назначение повторных измерений и понятный пациенту следующий шаг.

Для MVP достаточно согласованного перехода к видеоприему; собственную видеоплатформу можно отложить. Запись разговора необязательна и требует отдельного порядка. Плохая связь или необходимость осмотра - основание выбрать другой формат.

ICC показывает согласованность измерений, а не процент точности диагноза. Российский порядок телемедицины, включая приказ №193н от 11.04.2025, и допустимый объем конкретного приема проверяются отдельно. Видеосвязь не является обязательной для любого пациента.

Источники: [8], [9], [10], [13], [32].

HCL-33: дополнительная клиническая ветвь

Присланный большой опрос - HCL-33, Hypomania Checklist. Его 33 основных пункта относятся к состояниям подъема; вопросы о сегодняшнем состоянии, обычном темпераменте, длительности и последствиях сохраняются отдельно.

Гипомания простыми словами

Это эпизодическое изменение настроения и активности по сравнению с обычным состоянием; могут меняться сон, темп мыслей, общение и поведение. Один хороший день, высокая общительность или занятость не устанавливают гипоманию. Мания отличается выраженным нарушением состояния и функционирования, может сопровождаться психотическими симптомами и требовать срочной помощи. Диагностические критерии оценивает психиатр.

Зачем в проекте	Как реализовать
Уточнить периоды подъема при депрессивных жалобах	Назначает специалист, независимо от PHQ/GAD. Это помогает уточнению биполярного спектра, но не ставит диагноз.
Сохранить клинический контекст	Длительность, влияние на жизнь, реакции близких, обычный уровень и связь с веществами/лечением обсуждаются в беседе.
Посчитать основной блок	0-33: число «да» в 33 симптомных пунктах. Дополнительные вопросы в сумму не включаются.

Русская валидация

Mosolov и соавт., 2021: 150 пациентов с исходным диагнозом РДР в двух московских учреждениях; диагностический ориентир MINI. AUC=0,773, α=0,91, чувствительность 0,71 и специфичность 0,69 около указанной авторами точки 16. Это клиническая выборка, не массовая студенческая популяция.

Точный оператор границы «≥16» или «>16» не кодировать по пересказу абстракта: требуется сверка полного ключа выбранной формы. Пока показывать сумму и исходные ответы специалисту без автоматической категории «БАР». В найденной редакции КР по депрессии HCL-33 - Г3; по БАР 2025 - Г5.

Источники: [11], [29], [30].

Разработчику: сущности и состояния данных

Сущность	Минимальные поля
Пользователь / связь со специалистом	Псевдонимный ID, роль, возрастная область, назначенная команда; идентифицирующие сведения отдельно от аналитики.
Согласие	Вид, версия текста, цель, дата, способ подтверждения, отзыв и основания последующего хранения.
Форма и назначение	scale_id, версия, язык, источник, права; назначение, автор, период, срок, допустимые значения и правила ветвления.
Оценочная сессия	session_id, reference_start/end, время начала/завершения, способ проведения, полнота и статус.
Ответ	item_id, значение или null, статус, время, версия и история; исходный ответ пациента отдельно от записи специалиста.
Комментарий и аудио	Связь с вопросом, оригинал, права доступа, расшифровка, ее статус проверки, длительность, срок хранения.
Результат	Алгоритм и версия расчета, входные ответы, полнота, итог или null, тип самоотчет/врачебный/исследовательский.
Событие безопасности	Фактическое основание, время, протокол, ответственный, доставка, подтверждение, действия, резерв и завершение.
Журнал	Кто прочитал/изменил/экспортировал, когда и на каком основании; без лишнего содержания здоровья в технических логах.

Состояния ответа

answered - ответил; **unanswered** - не отвечал; **deferred** - отложил; **declined** - отказ; **not_asked_by_rule** - вопрос не задан по алгоритму. Во всех состояниях без ответа значение null. Для врачебного пункта отдельно: draft / confirmed.

Перепутать not_asked_by_rule и «нет» нельзя: иначе меняется медицинский смысл данных. «Нет подходящего ответа» относится к неопределенности/комментарию, если такого варианта нет в официальной шкале; произвольные числа ему не присваиваются.

Разработчику: переходы и исключения

Шаги ТЗ	Пациент / программа / специалист	Данные и исключения
1-4: открытие, приветствие, FAQ, вопрос	Чтение без обязательной регистрации; обращение по желанию. Срочный маршрут доступен сразу.	Просмотр не создает диагноз или заполненную форму; вопрос не публикуется автоматически.
5: согласие	Сервис показывает конкретные правила; человек принимает решение.	Версия и способ согласия. Отказ не закрывает общую информацию и помощь.
6-7: безопасность	Короткая форма по утвержденному сценарию; команда реагирует.	Состояния и события отдельно от баллов. Сбой доставки не скрывается за статусом «готово».
8-11: короткие и полные формы	PHQ-4, расчет двух подшкал, предложение; специалист назначает или заранее утвердил пакет.	Период, версия, причина назначения. При отсутствии ответа - незавершено, не 0.
12-13: расчет и сводка	Рассчитать допустимые суммы и предоставить исходные данные специалисту.	PHQ-ADS только при совместимых полных шкалах. Противоречия помечаются для беседы.
14-15: прием и дополнительные формы	Видео по необходимости; назначенные MADRS/HDRS/HCL.	Формат, оценщик, подтверждения; при плохой связи перейти к резервному каналу.
16-17: клиническая оценка и наблюдение	Специалист оформляет вывод, обсуждает план и повторные измерения.	Отдельная подписанная запись; автоматическое назначение препаратов отсутствует.

Обязательные технические свойства

Идемпотентное сохранение ответов и событий; защита от повторной отправки; явный статус синхронизации; сохранение черновика с понятными границами. Для безопасности работа только локального черновика не равна уведомлению команды. Возобновление после смены периода требует проверки актуальности ответов.

Пропавшая сеть, окончание доступа, сбой распознавания, закрытие приложения, просроченное назначение и недоступность специалиста должны иметь отдельные понятные состояния. Сервис не выдает молчаливый «успех», если нужная операция не завершилась.

Критерии приемки: проверять до демонстрации

Тестовый сценарий	Ожидаемый результат
PHQ-2/GAD-2 по 2 и по 3	Предложение полной формы появляется только по правильной подшкале; сумма PHQ-4 ее не заменяет.
Все ответы 0 / все ответы 3	PHQ-9: 0/27, GAD-7: 0/21, PHQ-4: 0/12. При полных обеих шкалах PHQ-ADS: 0/48.
Один ответ отсутствует / отказ / 0	Различаются во входных данных и отчете; неполная сумма не становится стандартным итогом.
C-SSRS: вопрос 2 «нет»	3-5 не задаются, статус not_asked_by_rule; 6 предусмотрен всегда.
C-SSRS: вопрос 2 без ответа	Не выполняется отрицательная ветвь; скрининг неполный.
Пункт 9 PHQ-9 >0 при малой сумме	Событие для клинического уточнения не зависит от PHQ-ADS или старого C-SSRS.
Разные периоды PHQ-9/GAD-7	PHQ-ADS не формируется; отображается причина.
MADRS 9/10 confirmed; изменение пункта	Итога 0-60 пока нет; изменение снимает подтверждение; история сохранена.
HCL-33: 33 «да» плюс контекст	Сумма 33, не больше; ответы о сегодняшнем состоянии и темпераменте не прибавляются.
Аудио не распознано / ошибочно распознано	Исходник доступен по правам; баллы не меняются; черновик текста помечен.
Сбой уведомления или сотрудник не подтвердил	Виден сбой/ожидание, запускается настроенный резерв; нет ложного сообщения «специалист уже помогает».
Чужой пациент / университет / гостевой доступ	Нет доступа к индивидуальным медицинским ответам; попытка зарегистрирована.

Проверять на синтетических данных. Это минимальные содержательные тесты клинических правил, а не доказательство безопасности реального внедрения. После экспертной проверки отдельно проверяют доступность, понятность и работу команды при сбоях.

Регулирование, ПО и существующий код

Область	Практическое решение
Персональные данные и медтайна	152-ФЗ и 323-ФЗ: назначить оператора, основания, получателей, меры доступа и хранения. Согласие, информирование и медицинская документация - отдельные задачи.
Недобровольная помощь	Закон №3185-1 и клинический порядок: решение не принимается алгоритмом по одному ответу. Страх госпитализации обсуждается честно и без гарантий невозможности такой помощи.
Телемедицина	Проверить допустимый вид приема, идентификацию, медицинскую организацию и требования действующего порядка, включая №193н.
ПО как медицинское изделие	Оценивать заявленное назначение и конкретные функции по ст.38 323-ФЗ и материалам Росздравнадзора. Статус исследовательского прототипа сам по себе не освобождает клинический продукт от требований.
Функции потенциального медицинского назначения	Клиническая интерпретация, персональные рекомендации и маршрутизация требуют отдельного анализа. Даже наличие специалиста в цепочке не дает автоматически отрицательного ответа о регистрации.
Адаптация чужого кода	Проверить лицензию конкретного репозитория и зависимостей, разрешение модификации/распространения, требования уведомлений и передачи исходников. Не загружать реальные данные в демонстрационные сервисы.

Квалификация именно этого ПО, класс риска, необходимость и маршрут регистрации в настоящей работе не установлены. Нужен анализ фактического назначения с медицинской организацией и компетентным регуляторным специалистом. Формулировка «без ИИ» сама по себе вопрос не решает.

Для конкурсного прототипа: учебные данные, явные демонстрационные состояния, сохраненные источники и лицензии. До работы с пациентами - клиническая и организационная проверка конкретной модели. Это открытые задачи реализации, а не необходимость остановить подготовку макета или документа.

Источники: [13], [31], [32], [33], [34].

Сравнение с mindLAMP и исследовательская новизна

Функция	Что уже есть в mindLAMP	Как оценивать наш вклад
Опросники	Есть PHQ-9, GAD-7 и другие готовые/настраиваемые формы.	Нельзя заявлять, что платформа использует только PHQ-9. Проверять русские версии и окна оценки.
Комментарии и голос	Свободный текст в опросах; отдельные голосовые активности.	Связка комментария с конкретным пунктом, проверкой расшифровки и клиническим уточнением требует сравнительной проверки.
Дистанционное наблюдение	Пациентское приложение, кабинет команды, расписание, графики и индивидуальные задания.	Эти базовые возможности сами по себе не являются уникальной инновацией.
Доверие и конфиденциальность	Есть документация безопасности; точное наличие нашего сценария во всех внедрениях не проверено.	Проверяем гипотезу понятного русского вступления и FAQ для студентов. Не называем отсутствие функции доказанным.
Клиническое реагирование	Зависит от конфигурации и службы конкретного проекта.	Проверяем прослеживаемую передачу сигнала и работу специалиста, а не только показ балла.

Особенность документации mindLAMP, важная разработчику

В описании опросов указан локальный автосейв незавершенного прохождения; частичные ответы не передаются на сервер. Если брать эту архитектуру за основу, для нового сигнала безопасности нужно отдельное событие с проверяемой доставкой. Локальное сохранение не означает, что команда узнала об ответе.

> Потенциальная новизна - проверенный сценарий раскрытия, понятных объяснений и работы с неоднозначными ответами в конкретной русскоязычной студенческой среде. До сравнительного исследования это гипотеза и направление разработки.

Источники: [35].

Полине: последовательность разработки MVP

Этап	Сделать сейчас	Критерий готовности
1. Зафиксировать спецификацию	Роли, источники форм, согласованный сценарий безопасности и базовые данные; выбрать разрешенный исходный код.	Есть медицинский владелец правил и примеры входов/выходов.
2. Собрать сквозной учебный путь	Вступление, FAQ, экран согласия; C-SSRS по демонстрационному протоколу; PHQ-4 и назначенные полные шкалы.	Один синтетический пациент проходит путь без потери ответов; ошибки видны.
3. Кабинет и расчеты	Сводка, исходные ответы, комментарии и полнота; PHQ-ADS с пометкой; журнал назначений.	Пройдены содержательные проверки расчетов и прав доступа.
4. Врачебные формы	MADRS с подтверждением пунктов; HDRS/HCL как подключаемые модули по готовности проверенных текстов.	Неоцененные пункты не равны 0; итог только после необходимой полноты.
5. Реагирование и проверка	Имитируемый цикл уведомлений и резерв, удобство на смартфоне, экспертный разбор.	Понятно, что является демонстрацией. Нет ложного обещания реального наблюдения.

Распределение работы

Дана: клинические источники, тексты пояснений, согласование с психиатром, сценарии и границы интерпретации. **Полина:** выбор кода, данные, интерфейс, расчеты, роли и тесты. **Медицинский партнер:** владелец клинического протокола, назначения и работающая организация помощи.

Не реализовывать все одновременно

Для первого показа достаточно текстовых комментариев и перехода к согласованному видеосервису. Аудио, анонимная очередь и вспомогательный ИИ добавляются после проверки базового пути и условий хранения. Приоритет определяется требованиями конкурса и готовностью клинических материалов.

Это план по результатам, без выдуманных сроков. Реальный календарь Полина оценивает после просмотра исходного кода.

Над чем еще поработать

Отдельный лист для будущего обсуждения. Эти идеи не становятся обязательными функциями первой сборки.

Версия / тема	Вопрос для следующего шага	Как проверить
MVP: язык и короткий экран	Какие слова понятны разным студентам? Где пояснение помогает, а где перегружает?	Когнитивные интервью с участниками; пересказ своими словами; проверка без подсказки ответа.
Версия 2: личный вопрос	Есть ли команда, которая реально ответит? Нужен ли конфиденциальный или отдельный анонимный канал?	Проверка процесса, журналов, сроков, модерации и ограничений помощи.
Версия 2: голос	Помогает ли короткая запись раскрыть контекст и сколько времени требует от специалиста?	Ошибки расшифровки, полезность контекста, время просмотра, возможность отказаться.
Исследование: вступление и FAQ	Улучшаются ли понимание правил и готовность к разговору?	Сравнение вариантов с неизменным сценарием безопасности; оценка понимания и приемлемости.
Исследование: PHQ-ADS и переходы	Сопоставимы ли русские формы, продолжение PHQ-4 и общий показатель у студентов?	Психометрический протокол, клинический ориентир и анализ пропусков.
Исследование: помощь с текстом	Уменьшает ли проверяемая структуризация работу специалиста?	Доля пропусков/ошибок, независимая проверка, отсутствие изменения баллов.
Отдельный будущий проект	Семейный анамнез и древо исключены из этой первой версии. Расширение на другие группы обсуждается отдельно.	Свой сценарий, источники, согласие и проверка пригодности.

Не измерять успех только числом «признаний» или положительных ответов. Важны понимание, добровольность, возможность получить помощь и качество клинической работы. Человек не должен чувствовать, что его заставляют раскрыться ради показателей приложения.

Источники: [16], [22], [24], [25], [28].

Требует подтверждения до внедрения

Открытый вопрос	Что сделать / кто отвечает
Русский шестипунктовый C-SSRS и self-report	Получить точную официальную форму, период, страну, назначение и права на реализацию; Дана, куратор, правообладатель.
Правила клинического реагирования	Утвердить события, ответственных, время подтверждения, резерв и документирование; медицинский партнер.
Русский PHQ-ADS для выбранных переводов	Не считать доказанным; подготовить исследовательское обоснование и пилот.
Порог HCL-33	Сверить полный первоисточник и точный ключ: пограничный оператор не угадывать по абстракту.
Права на формы и код	Условия конкретного перевода, критериев MADRS/HDRS, HCL и репозиториев; хранить подтверждения.
Оператор, хранение и согласия	Заполнить реальные реквизиты, основания и формы, сроки и получателей; медицинская организация и юрист.
Статус медицинского изделия	Оценить фактическое назначение и функции; не определен настоящим PDF.
Подростки младше 18 лет	Отдельный юридический и клинический сценарий; не включать по аналогии со взрослыми.
Истинная анонимность личных вопросов	Аудит связей с аккаунтом, логов, аналитики, метаданных и текстов; только после этого выбирать название функции.
Эффект экрана и неизвестная статья о терминах	Наши тексты пока проектные; точный источник из воспоминания Даны не идентифицирован.

Заключение для команды

Проект можно развивать как понятный путь к контакту со специалистом: короткая информация, добровольные ответы, отдельная безопасность и прослеживаемая клиническая работа. Подтвержденные свойства опросников, организационные требования и гипотезы интерфейса в этой спецификации разделены. Следующий результат - сквозная демонстрация и экспертная проверка.

Источники: [6], [16], [28], [29], [31], [32], [34], [36].

Русская форма PHQ-4

PHQ-4 = GAD-2 + PHQ-2. Порядок соответствует присланной российской адаптации: тревога - пункты 1 и 2, депрессивные симптомы - 3 и 4.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством	0	1	2	3
3. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
4. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3

Ключ

GAD-2 = 1+2, PHQ-2 = 3+4; каждая подшкала 0-6. Порог ≥3 относится к каждой подшкале отдельно и служит для скрининга. Это не диагностическое заключение.

> PHQ-4 - короткий вход. Если уже заполнены полные PHQ-9 и GAD-7, не требовать четыре дополнительных повторных ответа ради такого же содержания.

Неполная подшкала не получает стандартного итога. Завершенную вторую подшкалу можно сохранить отдельно с показом полноты всего PHQ-4. Общее значение 0-12 не включает безопасность.

Русский текст предоставлен Даной и сверялся с приложением к статье Золотаревой, Костенко, Лебедевой и Чумаковой (2024), с.54. Формат таблицы изменен; содержание пунктов сохранено.

Источники: [1], [2].

Русская форма PHQ-9

Перевод из присланного приложения к статье А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
2. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3
3. Проблемы со сном (неспособность заснуть, раннее пробуждение или слишком долгий сон)	0	1	2	3
4. Чувство усталости или недостатка энергии	0	1	2	3
5. Плохой аппетит или переедание	0	1	2	3
6. Плохое мнение о себе или чувство, что не смог оправдать ожиданий моей семьи	0	1	2	3
7. Проблемы с концентрацией внимания (например, при чтении газеты или просмотре телевизионной передачи)	0	1	2	3
8. Замедленность движений или речи, которая стала заметна другим людям, или, напротив, суетливость, когда движения и речь стали более быстрыми и беспокойными	0	1	2	3
9. Мысли о том, что мне бы хотелось умереть или причинить себе боль	0	1	2	3

Обработка. Сумма всех девяти ответов 0-27. ≥10 - скрининговый ориентир для дальнейшей клинической оценки. Выраженность симптомов и диагноз не тождественны.

Пункт 9. Ответ >0 инициирует клиническое уточнение безопасности независимо от общего балла. Сервис сохраняет формулировку, исходное значение и период; комментарий не подменяет ответ. При пропуске стандартного итога нет.

Предоставленные Даной формулировки сохранены, включая особенности перевода пункта 6. Это выбранная версия, а не свободный пересказ для изменения при реализации.

Источники: [3], [14].

Русская форма GAD-7

Перевод из присланной статьи А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения.	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством.	0	1	2	3
3. Чрезмерное беспокойство по разным поводам.	0	1	2	3
4. Неспособность расслабляться.	0	1	2	3
5. Ощущение такого беспокойства, что трудно найти себе место.	0	1	2	3
6. Склонность быстро испытывать злость или раздражительность.	0	1	2	3
7. Чувство страха, как будто может случиться что-то ужасное.	0	1	2	3

Ключ

Сумма семи ответов 0-21. Диапазоны: 0-4 минимальные; 5-9 легкие; 10-14 умеренные; 15-21 тяжелые тревожные симптомы. Порог ≥10 - повод для клинического уточнения, не самостоятельный диагноз ГТР.

> Здесь оцениваются последние две недели. Диагноз ГТР требует более широкого клинического контекста и оценки течения; высокий результат может встречаться и при других состояниях.

Данный перевод отличается от текста формы в приложении к российским рекомендациям по ГТР. Не заменять отдельные пункты и варианты ответов по усмотрению разработчика. Выбранная форма хранится с версией, источником и условиями использования.

Источники: [4], [12], [15].

HCL-33: начало присланной формы

Рабочая копия текста Даны для обсуждения и сверки перед реализацией. Удалены технические подписи «Рисунок 190...» и восстановлена таблица. Содержание не является новой авторской шкалой.

1. Прежде всего, укажите, как Вы сегодня, по сравнению с Вашим обычным состоянием:

(Пожалуйста, выберите только одно утверждение из перечисленных.)

Варианты ответа
Намного хуже, чем обычно
Хуже, чем обычно
Немного хуже, чем обычно
Не лучше, не хуже, чем обычно
Немного лучше, чем обычно
Лучше, чем обычно
Намного лучше, чем обычно

2. Как Вы обычно оцениваете себя по сравнению с другими людьми?

Вне зависимости от того, как Вы чувствуете себя сейчас, укажите, как Вы обычно воспринимаете себя с другими людьми. Выберите наиболее подходящую формулировку из перечисленных ниже. По сравнению с другими людьми мой уровень активности, энергичности и настроения...

Выберите одно утверждение
... всегда достаточно ровный и стабильный
... обычно выше
... обычно ниже
... повторяющиеся периоды подъемов и спадов

3. Попробуйте припомнить состояние «подъема»

Как Вы себя тогда чувствовали? Пожалуйста, ответьте на перечисленные утверждения вне зависимости от Вашего нынешнего состояния. Варианты «Да / Нет» для 33 пунктов приведены далее.

Пункты 1 и 2 этой страницы - контекст. Их варианты не переводятся автоматически в баллы 0-6 и не включаются в сумму 33 симптомных ответов.

Источники: [11], [29].

HCL-33: симптомные пункты 1-17

Часть 3 опросника. Вспомните состояние подъема независимо от нынешнего состояния. Для каждого утверждения выбирается «Да» или «Нет».

В этом состоянии:	Да	Нет
1. Мне требуется меньше сна		
2. Я чувствую себя более энергичным и активным		
3. Я более уверен в себе		
4. Работа доставляет мне больше удовольствия		
5. Я более социально активен (чаще звоню по телефону, чаще развлекаюсь)		
6. Мне хочется больше путешествовать и/или я больше путешествую		
7. Я вожу автомобиль с большей скоростью или чаще рискую во время вождения		
8. Я трачу больше денег, чем обычно (слишком много денег)		
9. Я чаще рискую в повседневной жизни (на работе или в других ситуациях)		
10. Я более активен физически (спорт и т.д.)		
11. Я планирую больше действий и проектов		
12. У меня больше идей, я становлюсь более креативным		
13. Я становлюсь менее застенчивым и "закомплексованным"		
14. Я одеваюсь и/или крашусь более ярко и экстравагантно		
15. Мне хочется встречаться с большим количеством людей или я действительно чаще общаюсь с людьми		
16. Я больше интересуюсь сексом и/или я становлюсь более сексуально активным		
17. Я больше говорю		

Эта страница содержит первые 17 пунктов единого основного блока; продолжение на следующей странице. Смысл формулировок предоставленного текста сохранен.

Источники: [11], [29].

HCL-33: симптомные пункты 18-33

Продолжение того же основного блока о состоянии подъема.

В этом состоянии:	Да	Нет
18. Я думаю быстрей		
19. Во время разговора я чаще шучу и "каламбурю"		
20. Я легко отвлекаюсь		
21. Я вовлекаюсь во множество новых вещей		
22. Мои мысли перепрыгивают с одной темы на другую		
23. Я все делаю гораздо быстрее и/или легче, чем обычно		
24. Я более нетерпелив и/или легче раздражаюсь		
25. Я могу быть утомительным или раздражать окружающих		
26. Я чаще вступаю в ссоры		
27. Мое настроение более приподнятое и оптимистичное		
28. Я пью больше кофе		
29. Я выкуриваю большее число сигарет		
30. Я пью больше алкоголя		
31. Я принимаю больше лекарств (седативных, анксиолитиков, стимуляторов.)		
32. Я чаще играю или увлекаюсь азартными играми		
33. Я больше ем или я больше переедаю		

Для основной суммы учитываются только «да» в этих 33 пунктах. Если человек не может ответить или вопрос не подходит его опыту, сохранять неопределенность и комментарий; не проставлять «нет» автоматически.

Использование текста в этом рабочем документе не заменяет проверки выбранного ключа и условий его встраивания в приложение. Скрининг не устанавливает БАР.

Источники: [11], [29].

HCL-33: последствия, длительность, темперамент

Продолжение присланной формы. Все ответы этой страницы сохраняются как контекст, отдельно от суммы 33 пунктов.

4. Влияние «периодов подъема» на разные аспекты Вашей жизни

Область	Выберите вариант для каждой области
Семья	И положительное, и отрицательное / Положительное / Отрицательное / Никакого влияния
Общение	Те же четыре варианта
Работа	Те же четыре варианта
Досуг	Те же четыре варианта

5. Как Ваши близкие реагировали на Ваши «периоды подъема» и что они об этом говорили?

Положительная реакция (Вас ободряли и поддерживали); Нейтральная реакция; Отрицательная реакция (озабоченность, раздражение, неодобрение); И положительная, и отрицательная реакция; Никакой реакции.

6a. Сколько длился самый долгий «период подъема»? 6b. Как правило, сколько длится такой период?

Для каждого вопроса один вариант: 1 день; 2-3 дня; 4-6 дней; 1-3 недели; 1 месяц или дольше; Мне трудно судить / Я не знаю. Варианты сгруппированы из двухколоночного присланного текста; окончательный порядок сверить с исходной формой.

7. За последние 12 месяцев были ли у Вас «периоды подъема»?

Да / Нет.

8. Если да, сколько дней Вы провели в состоянии подъема за последние 12 месяцев?

Суммарно около _____ дней.

Два последних вопроса касаются темперамента

9. Можете ли Вы сказать, что Вам по натуре свойственны периоды подъемов и спадов? Да / Нет.
10. Иногда для Вас характерны внезапные перепады настроения? Да / Нет.

Мелкие орфографические и пунктуационные особенности нормализованы, технические подписи рисунков удалены. Перед клиническим запуском сверить форму целиком, включая инструкции и порядок вариантов.

Источники: [11], [29].

Реестр шкал: структура и назначение

Шкала / разработчики	Назначение и способ	Пункты / диапазон
C-SSRS Posner и соавт. / Columbia	Сведения о мыслях и поведении; точный формат интервью или self-report определяется выбранной версией.	Короткий Screener - 6; общий суммарный балл по типу PHQ не используется.
PHQ-4 Kroenke и соавт.	Короткий самоотчет о тревожных и депрессивных симптомах за 2 недели.	4; две подшкалы 0-6, общий 0-12.
PHQ-9 Kroenke, Spitzer, Williams	Самоотчет о депрессивных симптомах за 2 недели.	9; 0-27.
GAD-7 Spitzer и соавт.	Самоотчет о тревожных симптомах за 2 недели.	7; 0-21.
PHQ-ADS Kroenke и соавт.	Дополнительный расчет по заполненным PHQ-9/GAD-7 одной сопоставимой сессии.	16 уже имеющихся ответов; 0-48.
MADRS Montgomery, Asberg	Оценка тяжести и динамики обученным специалистом; инструкция конкретной формы.	10; каждый 0-6, итог 0-60.
HDRS-17 Hamilton	Клиническая оценка подготовленным специалистом; отдельные критерии и диапазоны пунктов.	17; стандартный итог 0-52.
HCL-33 Angst и соавт.; русская проверка Mosolov и соавт.	Самоотчет о периодах подъема, уточняемый клинически. Дополнительные вопросы о контексте отдельно.	33 симптомных пункта; 0-33.

В реестре продукта дополнительно обязательны ссылка на источник, дата/номер редакции, язык и страна, конкретная инструкция, права воспроизведения и версия алгоритма. Название шкалы без версии недостаточно для реализации.

Источники: [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9], [11], [14], [15], [28], [29].

Реестр: русские формы и клинические рекомендации

Шкала	Русская версия и данные	Статус и предел вывода
C-SSRS	Columbia публикует сведения о русских переводах; точный русский краткий self-report еще надо закрепить.	КР по БАР 2025: Г1. Это не одобрение любого шестипунктового цифрового перевода.
PHQ-4	Золотарева и соавт., 2024: N=2000, две подшкалы в общей популяции.	Самостоятельное включение именно этой формы в проверенные профильные КР не подтверждено.
PHQ-9	Золотарева, 2023: N=1800, α=0,89, факторная валидность.	Положительный самоотчет не диагноз. В проверенной КР по депрессии основной акцент на врачебных шкалах.
GAD-7	Золотарева, 2023: N=1130, α=0,93, общая популяция.	КР по ГТР 2024, Г2; формулировки отличаются от присланного перевода.
PHQ-ADS	Исходная проверка на 896 пациентах; отдельная проверка выбранной русской пары для студентов не найдена.	Не заявлять самостоятельное одобрение Минздравом; исследовательский дополнительный показатель.
MADRS	Русская форма в проверенной КР по депрессии; данные о видеосогласованности [8].	КР по депрессивному эпизоду/РДР 2024, Г2. Подготовленный оценщик.
HDRS-17	Русская форма в проверенной КР; исследования видео [9] и обучения [10].	Та же КР 2024, Г1. Присутствие перевода не равно валидации любого онлайн-интерфейса.
HCL-33	Mosolov и соавт., 2021: N=150, α=0,91, AUC=0,773.	КР по депрессии 2024, Г3; по БАР 2025, Г5. Не самостоятельная диагностика БАР.

Здесь указаны конкретно проверенные редакции. Факт наличия формы в рекомендациях, психометрическая валидация и право использовать ее в продукте - три разных основания. Актуальность официального текста перепроверяется перед клиническим внедрением.

Источники: [1], [3], [4], [6], [11], [12], [28], [29], [30].

Реестр: права и цифровое использование

Инструмент	Что известно об использовании	Что проверить для продукта
C-SSRS	Страница Columbia для обычной помощи допускает встраивание в EHR без специального разрешения; исследования имеют отдельные правила.	Точная русская форма, тип self-report, режим исследования и электронная реализация.
PHQ-4 / PHQ-9 / GAD-7	Источники указывают на доступность оригинальных инструментов для воспроизведения; статьи PsyJournals маркированы CC BY-NC 4.0.	Условия конкретного перевода и коммерческой реализации; не считать лицензию всей статьи и оригинала одним и тем же.
PHQ-ADS	Это сумма двух шкал; новых пациентских вопросов нет.	Права на используемые формы и графические материалы; валидность русской суммарной реализации.
MADRS	В КР доступна русская форма; это не универсальное доказательство отсутствия прав у владельцев шкалы и критериев.	Право встраивать точные тексты критериев и выбранное интервью. До подтверждения - ссылка на источник и структура карточек.
HDRS-17	Доступен клинический текст разных версий и руководств.	Права именно на выбранную русскую форму и инструкции; не переносить автоматически на все варианты Hamilton.
HCL-33	Присланный текст воспроизведен для рабочего обсуждения; есть русская публикация и формы в КР.	Условия правообладателя для конкретного приложения; сверка полного ключа и порядка вариантов.

Валидированный бумажный опросник не делает автоматически валидированным измененный цифровой сценарий. Для каждой формы сохраняются неизменные инструкция, временное окно, вопросы, варианты и ключ; дополнительные пояснения показываются отдельно и проверяются на влияние на ответы.

Документ не прикладывает полный текст критериев MADRS/HDRS и не создает новый перевод C-SSRS. Вместо неподтвержденного воспроизведения даны официальные источники, структура и задачи для проверки прав. Три основные формы и HCL-33 взяты из присланных пользователем материалов.

Источники: [1], [3], [4], [6], [11], [12], [29], [36].

Для Даны: порядок дальнейшего чтения

Приоритет	Что читать	Что выписать для проекта
1. Причины молчания	McGillivray [16] и Blanchard/Farber [17].	Какие барьеры обнаружены, как собраны данные, чего исследование не доказывает.
2. Разговор и доверие	Ford [20], Gould [18], Dazzi [19], альянс [24].	Границы обещаний, прямые вопросы, необходимость подготовки специалиста.
3. Именно студенты	eBridge: сначала пилот [21], затем большое РКИ [22]; CAMS [23].	Отличать ранний позитивный сигнал от подтвержденного эффекта и терапии от цифрового входа.
4. Измерения	Русские PHQ/GAD [1,3,4], PHQ-ADS [28], HCL-33 [29].	Выборки, версии переводов, ключи, назначение и ограничения переноса на студентов.
5. Клинический процесс	Columbia [5,6,36], NICE [7], WHO [27], врачебные шкалы и видео [8-11].	Как организовать помощь после ответа и хранить данные для клинического уточнения.
6. Реализация	mindLAMP [35], нормы [13,31-34].	Какие функции уже есть, какие права и организационные условия нужно подтвердить.

Короткий шаблон заметки о статье

Вопрос → дизайн → кто участвовал → что сравнивали → результат → ограничение → какое решение проекта поддерживает.
Если работа наблюдательная, не переписывать ее вывод как причинное доказательство. Если испытание проведено в другой популяции, прямо отметить переносимость.

В библиографии ниже сохранены кликабельные ссылки и пояснения. Для индивидуальной работы можно читать источники по этим приоритетам, не пытаясь разбирать весь список одновременно.

Источники и заметки · 1/5

Проверено при подготовке 17.10.2026. Номера в основном тексте кликабельны; ссылки ниже открывают источники.

[1] Золотарева А.А., Костенко В.Ю., Лебедева А.А., Чумакова М.А. (2024). Скрининг тревоги и депрессии в общей популяции: адаптация Patient Health Questionnaire-4 в России. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 58(2), 45-54.
Открыть источник
Полный текст и русская форма на последней странице. DOI в метаданных: 10.31363/2313-7053-2024-899.

[2] Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B.W., Löwe B. (2009). An ultra-brief screening scale for anxiety and depression: the PHQ-4. Psychosomatics, 50(6), 613-621.
Открыть источник
Первичная публикация о комбинации двух коротких подшкал. DOI: 10.1176/appi.psy.50.6.613.

[3] Золотарева А.А. (2023). Диагностика депрессии: психометрическая оценка русскоязычной версии опросника здоровья пациента (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9). Клиническая и специальная психология, 12(4), 107-121.
Открыть источник
Русская форма в приложении. DOI: 10.17759/cpse.2023120406. Выпуск датирован 2023 годом, на сайте указана публикация 13.02.2024.

[4] Золотарева А.А. (2023). Адаптация русскоязычной версии шкалы генерализованного тревожного расстройства (Generalized Anxiety Disorder-7). Консультативная психология и психотерапия, 31(4), 31-46.
Открыть источник
Русская форма в приложении. DOI: 10.17759/cpp.2023310402.

[5] The Columbia Lighthouse Project. C-SSRS Screen with Triage Points for Outpatient/Ambulatory (форма 2026).
Открыть источник
Официальный англоязычный протокол: порядок 1-2, условные 3-5, обязательный вопрос 6 и временные окна.

[6] The Columbia Lighthouse Project. Translations.
Открыть источник
Официальная страница переводов и доступа к русским формам. Для проекта выбрать точную версию и ее назначение; собственный перевод здесь не предлагается.

[7] NICE. Self-harm: assessment, management and preventing recurrence (NG225), раздел 1.6.
Открыть источник
Официальные рекомендации: ограничения шкал для предсказания суицида и принятия решений о помощи. Это международное руководство, а не российская регуляторная норма.

[8] Kobak K.A., Williams J.B.W., Jeglic E., Salvucci D., Sharp I.R. (2008). Face-to-face versus remote administration of the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale using videoconference and telephone. Depression and Anxiety, 25(11), 913-919.
Открыть источник
Первичное исследование MADRS: видео и телефон. DOI: 10.1002/da.20392. PubMed PMID: 17941100.

Источники и заметки · 2/5

Проверено при подготовке 17.10.2026. Номера в основном тексте кликабельны; ссылки ниже открывают источники.

[9] Kobak K.A. (2004). A comparison of face-to-face and videoconference administration of the Hamilton Depression Rating Scale. Journal of Telemedicine and Telecare, 10(4), 231-235.
Открыть источник
Первичное исследование: сопоставление видео и очного интервью, ICC=0,88. DOI: 10.1258/1357633041424368.

[10] Kølbæk P. и соавт. (2025). Improving the Accuracy and Reliability of Ratings on the Hamilton Depression Rating Scale via a Video-Based Training Program. Acta Psychiatrica Scandinavica, 152(6), 462-472.
Открыть источник
Подготовка оценщиков: 110 сотрудников, 43% → 70% в допустимом отклонении от эталона. DOI: 10.1111/acps.70029.

[11] Клинические рекомендации «Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство», редакция 2024, ID 301, версия 301_3; раздел 2.1 и приложения Г1/Г2.
Открыть источник
Официальная карточка. Текст проверен по доступной копии редакции от 26.08.2024: Открыть доступную копию. Перед внедрением перепроверить актуальную редакцию в Рубрикаторе.

[12] Клинические рекомендации «Генерализованное тревожное расстройство», редакция 2024, ID 457, версия 457_3, приложение Г2.
Открыть источник
Официальная карточка. Доступный текст приложения: Открыть доступную копию. Формулировки отличаются от присланного перевода GAD-7.

[13] Приказ Минздрава России от 11.04.2025 №193н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».
Открыть источник
Копия зарегистрированного нормативного документа. Организацию реального видеоприема согласует медицинская организация с учетом действующих норм и конкретного вида помощи.

[14] Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B.W. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613.
Открыть источник
Первичная публикация PHQ-9; правила и клиническая интерпретация показателей.

[15] Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B.W., Löwe B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092-1097.
Открыть источник
Первичная публикация GAD-7. DOI: 10.1001/archinte.166.10.1092.

Источники и заметки · 3/5

Проверено при подготовке 17.10.2026. Номера в основном тексте кликабельны; ссылки ниже открывают источники.

[16] McGillivray L., Rheinberger D., Wang J., Burnett A., Torok M. (2022). Non-disclosing youth: a cross sectional study to understand why young people do not disclose suicidal thoughts to their mental health professional. BMC Psychiatry, 22, 3.
Открыть источник
DOI: 10.1186/s12888-021-03636-x. Начать с методов и таблицы 3. N=513; Австралия, 16-25 лет; поперечный онлайн-опрос. Это источник присланных процентов, а не испытание нашего интерфейса.

[17] Blanchard M., Farber B.A. (2020; онлайн 2018). “It is never okay to talk about suicide”: Patients’ reasons for concealing suicidal ideation in psychotherapy. Psychotherapy Research, 30(1), 124-136.
Открыть источник
DOI: 10.1080/10503307.2018.1543977. Качественные ответы 66 клиентов, скрывавших мысли. Читать о страхе последствий раскрытия; не смешивать выборку с N=513 в [16].

[18] Gould M.S. и соавт. (2005). Evaluating iatrogenic risk of youth suicide screening programs: a randomized controlled trial. JAMA, 293(13), 1635-1643.
Открыть источник
N=2342 школьника, 6 школ. Проверка опасений о вреде самого расспроса. Результаты не освобождают сервис от клинического реагирования и наблюдения за дистрессом.

[19] Dazzi T., Gribble R., Wessely S., Fear N.T. (2014). Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence? Psychological Medicine, 44(16), 3361-3363.
Открыть источник
Обзор исследований о прямых вопросах. Полезен для обучения специалистов. Отсутствие выявленного увеличения мыслей не означает доказанную безвредность любого текста или интерфейса.

[20] Ford C.A. и соавт. (1997). Influence of physician confidentiality assurances on adolescents’ willingness to disclose information and seek future health care: a randomized controlled trial. JAMA, 278(12), 1029-1034.
Открыть источник
DOI: 10.1001/jama.1997.03550120089044. N=562; оценивалась готовность подростков после разных объяснений конфиденциальности. Не оправдывает обещания абсолютной тайны.

[21] King C.A. и соавт. (2015). Online suicide risk screening and intervention with college students: a pilot randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(3), 630-636.
Открыть источник
N=76 студентов. eBridge: обратная связь и необязательная переписка с консультантом по принципам мотивационного интервьюирования. Небольшой пилот, ограниченная переносимость результата.

[22] King C.A. и соавт. (2022). Electronic bridge to mental health for college students: a randomized controlled intervention trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 90(2), 172-183.
Открыть источник
DOI: 10.1037/ccp0000709. 4 университета; 3363 рандомизированных студента. В анализе по назначенному вмешательству не найден эффект на получение помощи. Важно для реалистичных ожиданий от цифрового контакта.

Источники и заметки · 4/5

Проверено при подготовке 17.10.2026. Номера в основном тексте кликабельны; ссылки ниже открывают источники.

[23] Pistorello J. и соавт. (2020, онлайн). A Randomized Controlled Trial of the Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) Versus Treatment as Usual (TAU) for Suicidal College Students. Archives of Suicide Research.
Открыть источник
DOI: 10.1080/13811118.2020.1749742. N=62; 4-8 недель. Читать как пример совместной клинической работы со студентом. Это терапия с подготовленным специалистом, не доказательство лечебного эффекта FAQ.

[24] Karver M.S. и соавт. (2018). Meta-analysis of the prospective relation between alliance and outcome in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 55(4).
Открыть источник
28 исследований, N=2419, r=0,19. Поддерживает внимание к рабочим отношениям; корреляция альянса с исходом не доказывает эффект одного приветственного экрана.

[25] SAMHSA (2014). SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach.
Открыть источник
Методическое руководство: безопасность, прозрачность, сотрудничество, выбор и учет контекста. Это рамка организации помощи, а не испытание нашего цифрового продукта.

[26] NICE (2021). Shared decision making, NG197.
Открыть источник
Совместное обсуждение вариантов и неопределенности, понятная информация и проверка понимания. Использовать как принципы коммуникации, не как российское правовое разрешение.

[27] WHO. mhGAP: Self-harm and suicide; assessment and safety planning recommendations, включая обновление 2023 года.
Открыть источник
Первичная оценка и повторное уточнение при необходимости, клиническая помощь и план безопасности. Временные окна WHO не подставлять в C-SSRS: соблюдать инструкцию выбранной формы.

[28] Kroenke K., Wu J., Yu Z., Bair M.J., Kean J., Stump T., Monahan P.O. (2016). The Patient Health Questionnaire Anxiety and Depression Scale (PHQ-ADS): Initial Validation in Three Clinical Trials. Psychosomatic Medicine, 78(6), 716-727.
Открыть источник
DOI: 10.1097/PSY.0000000000000322. N=896, три исследования боли/депрессии, включая онкологическую практику. Читать методы, валидность и ограничения до переноса на русскоязычных студентов.

[29] Mosolov S.N. и соавт. (2021). Validation of the Russian version of the hypomania checklist (HCL-33) for the detection of bipolar disorder in patients with a current diagnosis of recurrent depression. Journal of Affective Disorders Reports, 4, 100086.
Открыть источник
DOI: 10.1016/j.jadr.2021.100086. N=150, две московские психиатрические площадки; сопоставление с MINI. AUC=0,773, α=0,91; данные о границе 16 необходимо сопоставить с точным правилом конкретной формы.

Источники и заметки · 5/5

Проверено при подготовке 17.10.2026. Номера в основном тексте кликабельны; ссылки ниже открывают источники.

[30] Клинические рекомендации «Биполярное аффективное расстройство», редакция от 05.06.2025: C-SSRS и HCL-33.
Открыть источник
В доступном тексте: C-SSRS - приложение Г1; HCL-33 - Г5. Приведена воспроизведенная редакция документа. Перед внедрением проверить действующий официальный текст в Рубрикаторе Минздрава.

[31] Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», статьи 9, 10, 18 и другие применимые положения.
Открыть источник
Для проекта важны отдельное оформление согласия, специальные категории данных, правовое основание обработки, безопасность и применимые требования к базам данных. Текст договора и форму электронного согласия готовят под конкретного оператора.

[32] Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: статьи 13, 20, 36.2, 38.
Открыть источник
Официальная страница закона может содержать прежнюю редакцию; актуальную редакцию статьи 13 сверять отдельно: Открыть доступную копию. В документе дан рабочий перечень вопросов, не юридическое заключение.

[33] Закон РФ №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», статья 29.
Открыть источник
Основания и процедура недобровольной госпитализации определяются законом и клиническим решением. Отметка в приложении сама по себе таким решением не является.

[34] Росздравнадзор. Медицинские изделия; методические рекомендации по экспертизе ПО для государственной регистрации от 07.05.2024.
Открыть источник
Официальный раздел регулятора. Квалификацию ПО определяют по назначению и функциям, а не по слову «прототип». Класс и необходимость регистрации данного продукта здесь не установлены.

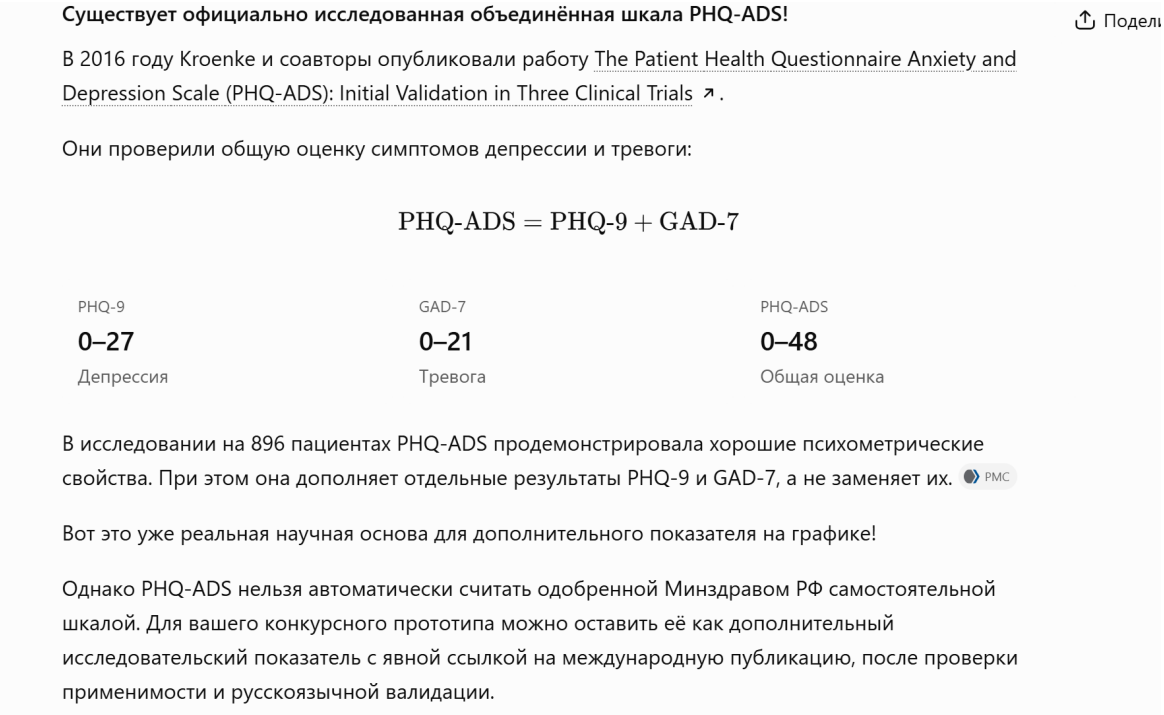
[35] mindLAMP. Официальная техническая документация: Surveys, Dashboard, Activities, Voice Recording и Portal.
Открыть источник
Проверка существующих функций: PHQ-9, GAD-7, настраиваемые опросы, свободный текст, голосовые активности, расписание и графики. Временные окна готовых шаблонов и лицензии выбранного репозитория проверять отдельно.

[36] The Columbia Lighthouse Project. Clinical/community use, self-report forms and separate research-use guidance.
Открыть источник
Страница обычного клинического применения допускает встраивание в EHR без специального разрешения. Для исследований и электронных реализаций проверить отдельные условия: Открыть доступную копию. Статус конкретной русской цифровой версии остается открытым.

[37] Horowitz L.M. и соавт. (2013). Ask suicide-screening questions to everyone in medical settings: the asQ'em Quality Improvement Project. Psychosomatics, 54(3), 239-247.
Открыть источник
Проект улучшения качества, не испытание интерфейса для студентов. Пример организации расспроса, работы персонала и маршрута после ответа; ссылка [72] в исследовании McGillivray.

Присланные материалы · 1/5

Исходные изображения Даны; материалы обсуждения, а не независимые клинические доказательства.



Существует официально исследованная объединённая шкала PHQ-ADS!

Подели

В 2016 году Kroenke и соавторы опубликовали работу The Patient Health Questionnaire Anxiety and Depression Scale (PHQ-ADS): Initial Validation in Three Clinical Trials ↗.

Они проверили общую оценку симптомов депрессии и тревоги:

$$\text{PHQ-ADS} = \text{PHQ-9} + \text{GAD-7}$$

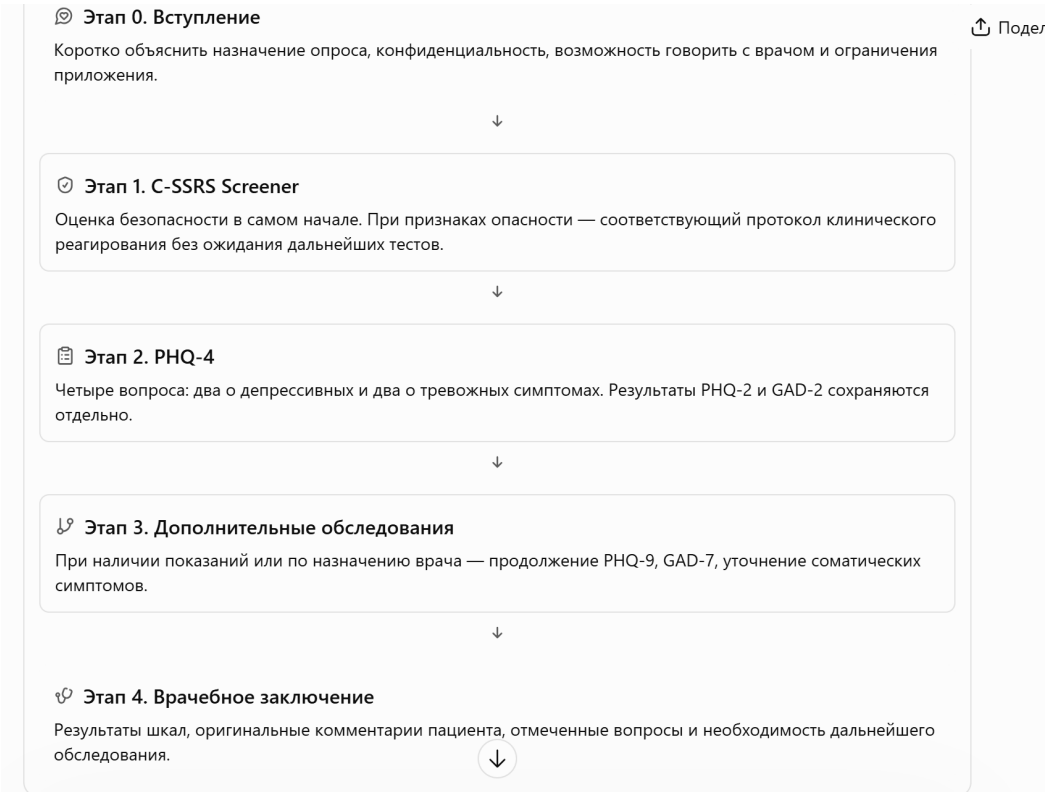
PHQ-9	GAD-7	PHQ-ADS
0–27	0–21	0–48
Депрессия	Тревога	Общая оценка

В исследовании на 896 пациентах PHQ-ADS продемонстрировала хорошие психометрические свойства. При этом она дополняет отдельные результаты PHQ-9 и GAD-7, а не заменяет их. PMC

Вот это уже реальная научная основа для дополнительного показателя на графике!

Однако PHQ-ADS нельзя автоматически считать одобренной Минздравом РФ самостоятельной шкалой. Для вашего конкурсного прототипа можно оставить её как дополнительный исследовательский показатель с явной ссылкой на международную публикацию, после проверки применимости и русскоязычной валидации.

PHQ-ADS: формула и исходная работа. В основном тексте отделены ее результаты от проверки русской реализации.



Подел

Этап 0. Вступление

Коротко объяснить назначение опроса, конфиденциальность, возможность говорить с врачом и ограничения приложения.

↓

Этап 1. C-SSRS Screener

Оценка безопасности в самом начале. При признаках опасности — соответствующий протокол клинического реагирования без ожидания дальнейших тестов.

↓

Этап 2. PHQ-4

Четыре вопроса: два о депрессивных и два о тревожных симптомах. Результаты PHQ-2 и GAD-2 сохраняются отдельно.

↓

Этап 3. Дополнительные обследования

При наличии показаний или по назначению врача — продолжение PHQ-9, GAD-7, уточнение соматических симптомов.

↓

Этап 4. Врачебное заключение

Результаты шкал, оригинальные комментарии пациента, отмеченные вопросы и необходимость дальнейшего обследования.

↓

Исходный маршрут. Дополнен необязательными объяснениями и точным разделением предложения и назначения.

Присланные материалы · 2/5

Исходные изображения Даны; материалы обсуждения, а не независимые клинические доказательства.

Там показана правильная идея условных переходов:



Именно такая последовательность приведена в официальном кратком протоколе Columbia ↗.
The Columbia Li...

Но я бы **не копировала из картинки готовые категории риска без клинической проверки**. Особенно важно не забыть шестой вопрос: даже при отрицательных ответах на вопросы о текущих мыслях история суицидального поведения может иметь большое клиническое значение.

Кроме того, в краткой C-SSRS не складывают ответы в единый числовой показатель по принципу PHQ-9. И положительный результат не означает автом[illegible]ески необходимость госпитализации — срочность действий определяется состоянием, конкретными ответами и оценкой специалиста.

Ветвление C-SSRS. Отдельно закреплены not_asked_by_rule и неполная оценка.

Да, если интервью дистанционно проводит специалист. И это подтверждено исследованиями.

Kobak et al., 2008 — дистанционная MADRS

В исследовании сравнили оценку депрессии при очном интервью, видеосвязи и телефонном разговоре. Для видеосвязи согласованность результатов была высокой: ICC = 0,94.

Читать исследование ↗ PubMed

Hamilton Depression Rating Scale — дистанционная оценка

В исследовании 2004 года оценка по видеосвязи показала высокую согласованность с очным интервью (ICC = 0,88). PubMed

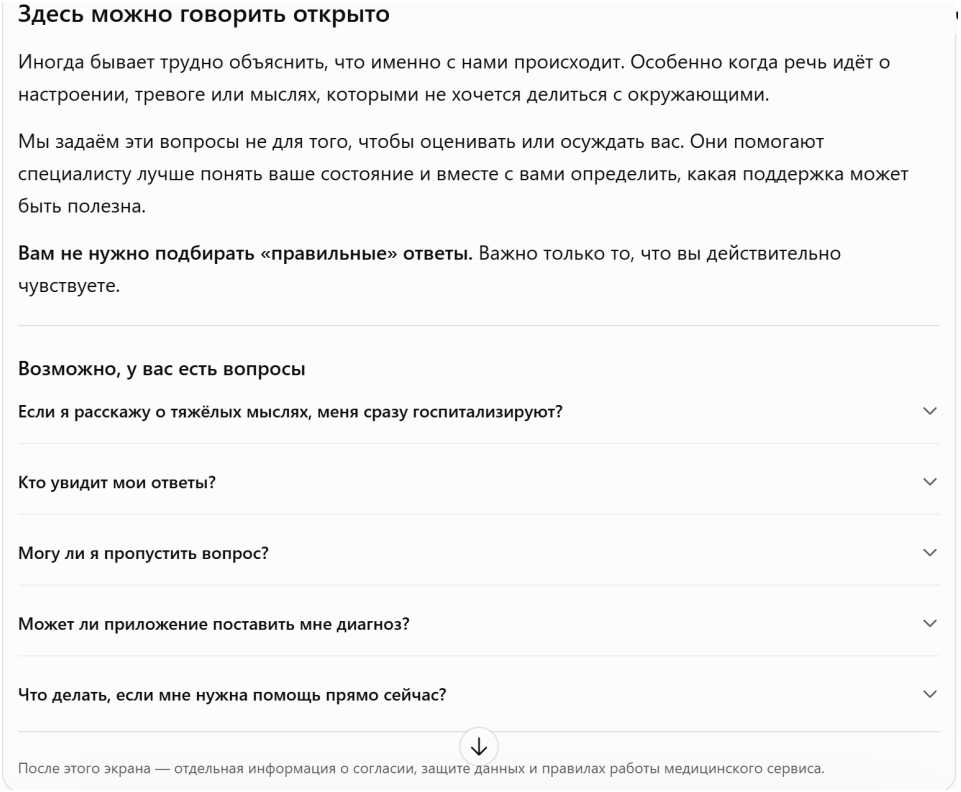
А исследование 2025 года показало, что даже медицинским специалистам необходима подготовка для достаточно надёжного выставления баллов по HDRS-17. PMC

Поэтому я вижу три уровня автоматизации.

Исследования видео. Числа и даты проверены; ICC не назван точностью диагноза.

Присланные материалы · 3/5

Исходные изображения Даны; материалы обсуждения, а не независимые клинические доказательства.



Здесь можно говорить открыто

Иногда бывает трудно объяснить, что именно с нами происходит. Особенно когда речь идёт о настроении, тревоге или мыслях, которыми не хочется делиться с окружающими.

Мы задаём эти вопросы не для того, чтобы оценивать или осуждать вас. Они помогают специалисту лучше понять ваше состояние и вместе с вами определить, какая поддержка может быть полезна.

Вам не нужно подбирать «правильные» ответы. Важно только то, что вы действительно чувствуете.

Возможно, у вас есть вопросы

- Если я расскажу о тяжёлых мыслях, меня сразу госпитализируют?
- Кто увидит мои ответы?
- Могу ли я пропустить вопрос?
- Может ли приложение поставить мне диагноз?
- Что делать, если мне нужна помощь прямо сейчас?

После этого экрана — отдельная информация о согласии, защите данных и правилах работы медицинского сервиса.

Предлагаемое вступление. В новой редакции уточнены медицинская цель и пределы обещаний.

Важное уточнение: приведённая тобой таблица с 513 участниками относится к исследованию **Non-disclosing youth: a cross sectional study to understand why young people do not disclose suicidal thoughts to their mental health professional** (2022), а не к работе Blanchard и Farber.

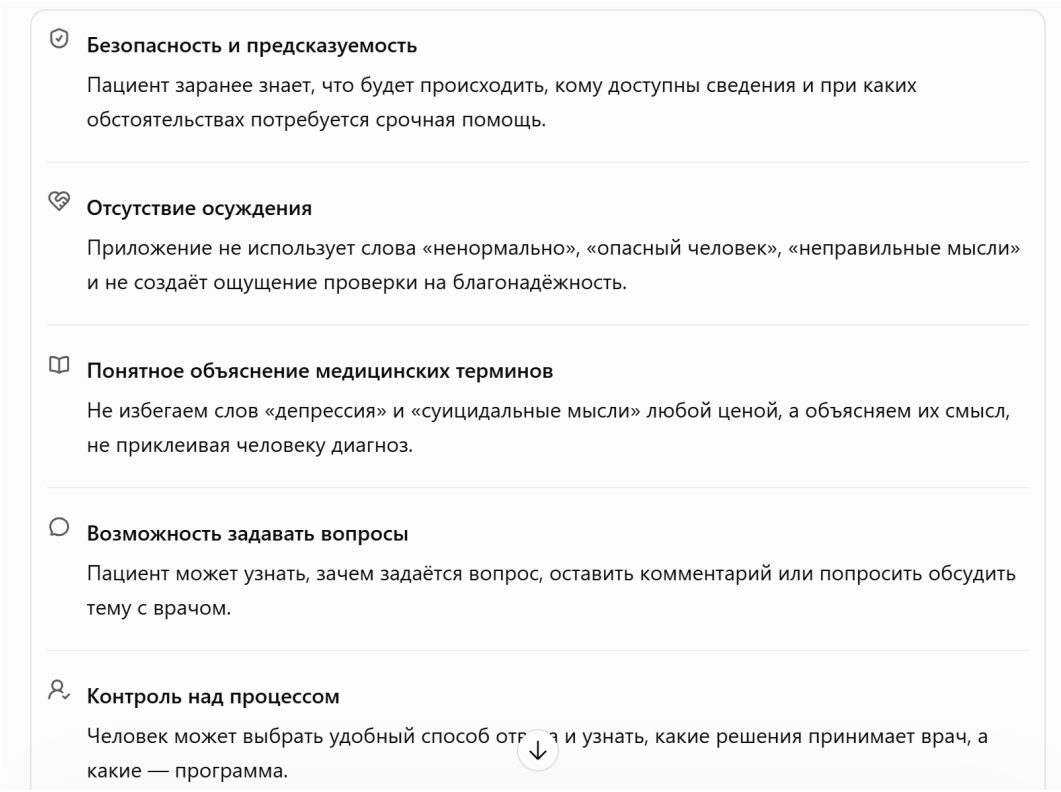
Твои проценты особенно интересны, потому что они фактически показывают, какие элементы стоит включить в интерфейс.

Что мотивировало бы раскрыть мысли	Как применить в приложении
Конфиденциальность — 66,3%	Понятно объяснить, кто видит ответы и когда конфиденциальность может быть ограничена
Прямой вопрос специалиста — 54,2%	Задавать прямые вопросы, не заменяя их расплывчатыми формулировками
Уверенность, что помощь существует — 53,4%	Объяснить, что с суицидальными мыслями можно обращаться за помощью
Реакция без осуждения — 52,4%	Использовать спокойные, нейтральные формулировки
Усиление мыслей — 52,0%	Объяснить, почему лучше не ждать ухудшения
Влияние на учёбу, работу и отношения — 47,0%	Показать, что помощь можно искать ещё до серьёзного нарушения повседневной жизни

Мотивация раскрытия: проценты отнесены к McGillivray 2022, N=513.

Присланные материалы · 4/5

Исходные изображения Даны; материалы обсуждения, а не независимые клинические доказательства.



Принципы общения: безопасность, выбор, отсутствие осуждения и понятные термины.

Ты правильно заметила кажущееся противоречие: одних людей медицинские термины пугают, а другим помогает, когда специалист прямо называет проблему.

Поэтому я бы использовала **двухуровневую коммуникацию**.

Сначала — мягкое объяснение: «Иногда у людей возникают мысли о смерти или о том, чтобы причинить себе вред».

Затем — прямой стандартизированный вопрос C-SSRS или другой выбранной шкалы, без изменения его клинического смысла.

И дополнительная кнопка «Что означает этот вопрос?».

Так мы не заставляем пациента сразу разбираться в медицинской терминологии, но и не скрываем от него, о чём спрашиваем.

Два уровня объяснения. Прямые стандартизированные вопросы сохраняются.

Присланные материалы · 5/5

Исходные изображения Даны; материалы обсуждения, а не независимые клинические доказательства.

Первая — анонимная библиотека вопросов и ответов. Она доступна до регистрации и не требует передачи личных данных. Это самый простой и безопасный вариант для первой версии.

Вторая — задать свой вопрос специалисту. Здесь важно различать настоящую анонимность и конфиденциальное обращение. Если вопрос связан с аккаунтом, номером телефона или историей опросов, он уже не обязательно анонимен. Кроме того, если врач отвечает не сразу, нельзя создавать впечатление, что это канал экстренной помощи.

Два типа вопросов: открытый FAQ и личное обращение с разными свойствами приватности.

Авторы обращают внимание не только на пациентов, но и на врачей.

Специалист может сам испытывать дискомфорт, когда нужно прямо спросить о самоубийстве, опасаться навредить таким вопросом или не знать, как реагировать на положительный ответ.

Исследования, на которые ссылаются авторы, поддерживают обучение специалистов навыкам прямого расспроса, оценки безопасности и реагирования. При этом прямые вопросы о суициде сами по себе не считаются причиной возникновения суицидальных мыслей.

Для вашего продукта отсюда следует интересная идея: **не только обучать пациента, но и поддерживать врача**.

Например, рядом с результатом C-SSRS можно показывать краткую памятку: какие уточняющие вопросы необходимы, как объяснить конфиденциальность, как действовать при выявлении риска и какие действия документировать.

Это не инструкция ИИ самостоятельно оценивать пациента, а структурированная клиническая поддержка для подготовленного специалиста.

Поддержка специалиста. Памятка дополняет обучение, но не заменяет его.